

社会医学

华西大纲 · PPT · 历年真题整理
复习笔记

2026 年 6 月 8 日

greedyCat

使用说明	6
第一章 绪论	7
1.1 社会学概述	7
1.1.1 社会医学的研究对象	7
1.1.2 社会医学的研究内容	7
1.2 社会医学的任务	7
1.3 社会医学的发展历史	8
1.3.1 国外社会医学发展	8
1.3.2 我国社会医学发展	8
1.4 社会医学的特色理论与创新观点	8
1.5 复习题	9
第二章 医学模式	11
2.1 医学模式的概念	11
2.2 医学模式的演变过程	11
2.2.1 神灵主义医学模式	11
2.2.2 自然哲学医学模式	11
2.2.3 机械论医学模式	12
2.2.4 生物医学模式	12
2.3 生物-心理-社会医学模式	12
2.3.1 产生的背景	13
2.3.2 恩格斯的生物-心理-社会医学模式	13
2.3.3 生物-心理-社会医学模式的意义	13
2.4 健康观的演变	13
2.4.1 消极健康观	14
2.4.2 WHO 健康观	14
2.4.3 健康与疾病概念的扩展	14
2.5 复习题	14
第三章 健康社会决定因素	17
3.1 社会因素概述	17
3.2 健康社会决定因素的概念	17
3.3 健康社会决定因素理论的发展	17
3.4 健康社会决定因素的理论模型	18
3.4.1 Dahlgren 和 Whitehead 模型 (1991)	18
3.4.2 WHO 的 SDH 行动框架	18
3.5 影响健康的主要社会因素	18
3.5.1 社会因素影响健康的规律与特点	18
3.5.2 主要社会因素	19
3.6 将健康融入所有政策	19
3.7 复习题	19
第四章 社会经济因素与健康	21
4.1 经济发展水平的衡量指标	21
4.1.1 宏观经济指标	21
4.1.2 综合发展指标	21
4.2 健康的衡量指标	21
4.3 经济发展水平与健康的双向作用	22
4.3.1 经济发展对健康的促进作用	22
4.3.2 经济发展对健康的负面效应	22
4.3.3 健康对经济发展的促进作用	22
4.3.4 经济发展与健康的双向作用总结	23
4.4 健康投资	23

4.4.1	健康投资的内涵	23
4.4.2	健康投资效益分析	23
4.5	复习题	23
第五章	社会环境因素与健康	25
5.1	人口与健康	25
5.1.1	人口数量与健康	25
5.1.2	人口结构与健康（教学难点*）	25
5.1.3	人口素质与健康	25
5.1.4	人口流动与健康（教学难点*）	26
5.2	营养、食品安全与健康	26
5.2.1	营养与健康	26
5.2.2	食品安全	26
5.3	体力活动、职业压力与健康	26
5.3.1	体力活动与健康	26
5.3.2	职业压力与健康	26
5.4	城市化与健康	27
5.5	社会网络与社会支持	27
5.5.1	社会网络	27
5.5.2	人际关系与社会支持	27
5.6	家庭与健康	27
5.6.1	家庭的类型与功能	28
5.6.2	家庭对健康的影响	28
5.7	退休、失业与健康	28
5.8	社会阶层与健康	28
5.9	复习题	29
第六章	社会文化因素与健康	31
6.1	文化概述	31
6.1.1	文化的构成	31
6.1.2	文化的特征与类型	31
6.2	文化对人群健康的影响	31
6.2.1	文化影响健康的作用模式（教学难点*）	32
6.2.2	文化影响健康的特点	32
6.3	教育对健康的影响	32
6.4	科技进步对行为与健康的影响	32
6.5	风俗习惯对健康的影响	32
6.6	宗教与道德对健康的影响	32
6.6.1	宗教	33
6.6.2	道德	33
6.7	非主流文化对健康的影响	33
6.8	复习题	33
第七章	行为心理因素与健康	35
7.1	心理因素与健康	35
7.1.1	人格与健康	35
7.1.2	认知与健康	35
7.1.3	心理压力与健康（教学难点*）	35
7.2	健康相关行为	36
7.2.1	行为与健康相关行为	36
7.2.2	健康相关行为的基本特征	36
7.2.3	健康行为的观点与理论（教学难点*）	36
7.3	行为心理问题的干预	36
7.4	吸烟与控烟	37
7.4.1	吸烟的健康危害	37
7.4.2	控烟的政策措施	37
7.4.3	控烟倡导运动	37
7.5	复习题	37

第八章 社会医学研究方法	39
8.1 社会医学研究概述	39
8.1.1 社会医学的相关研究方法	39
8.1.2 社会医学研究的步骤	39
8.1.3 课题评价三原则	39
8.1.4 非概率抽样	39
8.2 定性研究	40
8.2.1 常用定性研究方法	40
8.2.2 定性研究资料的处理与分析	40
8.3 定量研究	41
8.3.1 访谈法与自填法	41
8.4 问卷设计	41
8.4.1 问卷的概念、类型和结构	41
8.4.2 问卷设计的原则和步骤	41
8.4.3 封闭式问题与开放式问题	42
8.4.4 问卷设计常见错误及注意事项	42
8.5 效度与信度	42
8.5.1 效度的概念与类型（教学难点*）	42
8.5.2 信度的概念与类型（教学难点*）	43
8.5.3 信度与效度的关系（教学难点*）	43
8.6 复习题	43
第九章 卫生服务研究	45
9.1 卫生服务研究概述	45
9.1.1 卫生服务研究的意义与目的	45
9.1.2 我国卫生服务研究的进展	45
9.1.3 卫生服务研究的内容	45
9.1.4 卫生服务研究的方法	45
9.2 卫生服务需要、需求与利用	46
9.2.1 基本概念（教学难点*）	46
9.2.2 影响卫生服务需要与利用的因素	46
9.2.3 常用指标	46
9.3 卫生资源	46
9.3.1 卫生人力资源	46
9.3.2 卫生费用	47
9.4 卫生服务的综合评价（教学难点*）	47
9.5 复习题	47
第十章 健康危险因素评价	49
11.1 健康危险因素概述	49
11.1.1 健康危险因素的分类	49
11.1.2 健康危险因素的特点	49
11.1.3 健康危险因素的作用过程	49
11.2 健康危险因素评价	49
11.2.1 评价步骤（教学难点*）	50
11.2.2 健康危险因素的个体评价方法	50
11.2.3 健康危险因素的群体评价方法	50
11.3 大数据与健康危险因素评价	50
11.4 复习题	51
第十二章 生命质量评价	53
12.1 生命质量的概念与构成	53
12.1.1 生命质量的概念	53
12.1.2 生命质量的构成	53
12.2 生命质量的评价内容与方法	53
12.2.1 评价内容	53
12.2.2 评价方法（教学难点*）	54
12.3 生命质量的测量工具	54

12.4 生命质量评价的应用	54
12.5 复习题	54
第十三章 社会卫生状况	56
13.1 社会卫生状况概述	56
13.1.1 社会卫生状况评价	56
13.2 人群健康状况的评价指标	56
13.2.1 单一型指标	56
13.2.2 复合型指标（教学难点*）	57
13.3 健康影响因素指标	57
13.3.1 人口学指标	57
13.3.2 社会发展指标（教学难点*）	57
13.3.3 健康公平指标	58
13.4 中国与全球社会卫生状况	58
13.4.1 中国社会卫生状况	58
13.4.2 全球健康状况与全球卫生	58
13.5 全球卫生策略	58
13.5.1 21 世纪人人享有卫生保健	58
13.5.2 初级卫生保健（PHC）	59
13.5.3 千年发展目标与可持续发展目标	59
13.6 复习题	59
第十四章 健康管理及治理	62
16.1 健康管理概述	62
16.1.1 健康管理产生的背景	62
16.1.2 健康管理的演变	62
16.1.3 健康管理的概念和内涵	62
16.1.4 现代健康管理的新特点	62
16.2 健康管理的基本内容与步骤	62
16.2.1 健康管理的基本步骤	63
16.2.2 健康管理策略（教学难点*）	63
16.3 健康治理	63
16.3.1 健康管理与健康治理的联系与区别	64
16.4 不同层次的健康管理与治理	64
16.5 复习题	64
第十七章 社区卫生服务	66
17.1 社区与社区卫生服务概述	66
17.1.1 社区的定义、类型与要素	66
17.1.2 社区卫生服务的概念与对象	66
17.1.3 全科医学	67
17.2 社区卫生服务的特点与内容	67
17.2.1 社区卫生服务的特点（教学难点*）	67
17.2.2 社区卫生服务的内容	67
17.3 社区卫生服务发展概况	67
17.3.1 国际发展	67
17.3.2 中国发展	67
17.4 社区卫生服务的管理（教学难点*）	68
17.4.1 服务方式与绩效评价	68
17.4.2 社区卫生服务的意义	68
17.5 复习题	68
第十八章 社会病防治	70
21.1 社会病概述	70
21.1.1 社会病的特点	70
21.2 攻击与暴力	70
21.2.1 基本概念	70
21.2.2 人际暴力（教学难点*）	71
21.3 自杀	71

21.3.1 自杀的发生率与分布特征	71
21.3.2 自杀的社会根源	71
21.3.3 自杀的预防	71
21.4 非故意伤害	72
21.5 成瘾行为	72
21.5.1 吸毒	72
21.5.2 问题饮酒行为	72
21.6 与性行为相关的社会病	72
21.7 精神障碍	72
21.8 复习题	73

- 本复习笔记严格依照《社会医学（ ）》教学大纲（2026 版）章节编排，重点内容与大纲标注的掌握内容一致。
- 各章末附有复习题（选择题、填空题、名词解释、简答题），题目主要来源于教学平台题库及大纲重点内容。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- 大纲中**句尾”*”** 标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 建议结合教师授课 PPT 中的标红内容重点复习。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾”*” = 教学难点

本章导览：掌握社会医学的概念、研究对象和研究内容；了解社会医学的任务与发展历程；理解社会医学的特色理论与创新观点。

1.1 社会医学概述

[概念] 概念释义：社会医学（Social Medicine）是研究社会因素与健康及疾病之间相互联系及其规律的一门科学，是医学与社会学、经济学、管理学等社会科学相互渗透融合形成的一门交叉学科。它从社会宏观视角出发，研究社会因素对人群健康的影响，探讨保障人群健康的社会策略和方法。

1.1.1 社会医学的研究对象

社会医学以**社会人群的健康**为研究对象，主要关注：

1. **社会因素与人群健康的相互作用关系**——研究社会政治、经济、文化、行为、环境等因素对人群健康的影响
2. **社会卫生状况及人群健康状况**——评价和描述人群健康状况及其变动规律
3. **改善社会卫生状况的策略与措施**——提出保护人群健康、提高健康水平的社会卫生对策
4. **社会医学研究方法**——运用社会学、流行病学、统计学等多学科方法开展研究

1.1.2 社会医学的研究内容

社会医学的三大研究内容

1. **研究社会卫生状况**——主要是人群健康状况。通过社会卫生调查，评价人群健康水平及其变动规律，发现主要社会卫生问题及高危人群。核心指标包括：死亡率、发病率、期望寿命、伤残调整寿命年（DALY）等。
2. **研究影响人群健康的因素**——特别是社会制度、经济状况、文化因素、人口发展、生活劳动条件、行为生活方式及卫生服务等社会因素对健康的影响。揭示社会因素与健康之间的因果关系及其强度。
3. **研究社会卫生策略与措施**——针对已发现的社会卫生问题及其原因，制定并实施有效的社会卫生策略与措施，包括卫生政策、卫生规划、卫生服务体系改革、健康促进等。

！重点掌握：社会医学与预防医学、社区医学、卫生管理学、医学社会学等学科既有联系又有区别：

- 预防医学侧重于生物、物理、化学因素对健康的影响及其预防
- 社会医学侧重于社会因素对健康的影响及社会性防治策略
- 社区医学侧重于社区范围内的卫生服务和健康管理
- 卫生管理学侧重于卫生系统的组织、管理和政策实施
- 医学社会学从社会学角度研究医学现象、医疗组织和医患关系

1.2 社会医学的任务

1. **倡导积极的健康观**——推动“生物-心理-社会医学模式”在医疗卫生实践中的贯彻，促进健康观念的更新
2. **发现和评价社会卫生问题**——通过社会卫生调查和研究，发现主要的社会卫生问题，评价其严重程度和影响范围

3. 揭示社会因素与健康的因果关系——阐明社会因素对人群健康的正面和负面影响及其作用机制
4. 制定社会卫生策略和措施——针对社会卫生问题提出科学、可行的干预对策，改善社会卫生状况
5. 培养社会医学专业人才——提高医疗卫生工作者的社会医学素养，适应新医学模式要求

1.3 社会医学的发展历程

1.3.1 国外社会医学发展

表 1.1: 社会医学发展史上的重要人物与贡献	
人物/时期	主要贡献
古希腊时期	希波克拉底（Hippocrates）提出环境与健康的关系，关注空气、水、土壤和居住条件对健康的影响
18-19 世纪	工业革命时期，城市化带来严重公共卫生问题，推动卫生改革运动
法国 Rochoux（1838）	首次提出“社会医学”概念
法国 Guérin（1848）	将社会医学分为社会生理学、社会病理学、社会卫生学、社会治疗学四部分
德国 Neumann（1813-1908）	强调“医学是一门社会科学”，健康是社会问题
德国 Virchow（1821-1902）	提出“医学科学的核心是社会科学”、“政治是更大范围的医学”，开展斑疹伤寒调查
德国 Grotjahn（1869-1931）	现代实验社会医学奠基人，1920 年创办柏林大学社会卫生学系
英国 19 世纪	Chadwick 推动公共卫生法案；Simon 开展社会卫生调查
WHO（1948 起）	提出健康定义；推动“人人享有卫生保健”全球战略（1978，Alma-Ata 宣言）

！重点掌握：社会医学发展的三个时期：

1. 萌芽期（19 世纪以前）：以临床医学和环境卫生学为基础，关注环境与疾病的关系

2. 创立期（19 世纪）：社会医学概念正式提出，卫生改革运动兴起，关注社会因素对人群健康的影响

3. 发展期（20 世纪至今）：社会医学成为独立学科，进入大学教育体系，WHO 推动全球卫生战略

1.3.2 我国社会医学发展

1. 古代：中医经典《黄帝内经》即重视环境、情志与社会因素对人体健康的影响，体现“天人合一”的整体医学思想
2. 近代（20 世纪初）：1910 年设立卫生检疫机构；1922 年《社会医学》概念传入中国；1941 年陈志潜等在河北定县开展农村卫生实验区，创建“定县模式”，被誉为“中国社区医学之父”
3. 新中国成立后（1949-）：1952 年设立卫生系，开展社会卫生教学；引进苏联保健组织学；开展爱国卫生运动
4. 改革开放后（1980-）：1980 年卫生部发布《关于加强社会医学与卫生管理学教学科研工作的通知》；1984 年第一本《社会医学》教材出版；各医学院校设立社会医学教研室
5. 21 世纪以来：社会医学与卫生事业管理学科蓬勃发展；健康中国战略实施；社区卫生服务和全科医学快速发展

1.4 社会医学的特色理论与创新观点

社会医学的特色理论

1. 社会健康观——健康不仅是生物学现象，更是社会现象。人群健康水平受到政治、经济、文化、环境等社会因素的综合影响

2. 社会因素决定论——社会因素是影响人群健康的根本原因，生物因素和行为因素受社会因素制约

3. 健康公平理论——关注不同社会阶层、地区、人群之间健康水平的差异，强调社会公正和健康公平

4. 整体健康观——健康是社会、心理、生物因素相互作用的综合体现，需从多维度认识健康

5. 大卫生观——健康不仅是卫生部门的责任，需要全社会参与，强调跨部门协作

6. 健康社会决定因素理论——WHO 倡导的健康社会决定因素框架，强调“从根源上解决健康不公平”

！重点掌握：社会医学的创新观点：

- **将健康融入所有政策（HiAP）**：健康不仅是卫生部门的职责，所有公共政策都应考虑对健康的影响
- **健康共治**：政府、社会、个人共同参与健康治理
- **全生命周期健康管理**：从出生到死亡的全过程健康维护
- **健康中国战略**：将人民健康放在优先发展的战略地位

1.5 复习题

一、选择题

1. 社会医学是研究什么的学科？
(A) 社会因素与健康及疾病之间相互联系及其规律
(B) 生物因素与疾病的关系
(C) 环境卫生与健康的关系
(D) 医疗技术与疾病治疗的关系
2. 首次提出“社会医学”概念的是哪位学者？
(A) Virchow
(B) Neumann
(C) Rochoux
(D) Grotjahn
3. 社会医学的三大研究内容不包括：
(A) 研究社会卫生状况
(B) 研究影响人群健康的因素
(C) 研究临床治疗方法
(D) 研究社会卫生策略与措施
4. 被誉为“现代实验社会医学奠基人”的是谁？
(A) Virchow
(B) Neumann
(C) Guérin
(D) Grotjahn

二、名词解释

1. 社会医学（Social Medicine）
2. 大卫生观
3. 将健康融入所有政策（HiAP）

三、简答题

1. 简述社会医学的研究对象与研究内容。
2. 试述社会医学的基本任务。
3. 简述社会医学的特色理论观点。
4. 简述我国社会医学发展的重要阶段及标志性事件。

参考答案要点

一、选择题

1. (A)；2. (C)；3. (C)；4. (D)

二、名词解释

1. **社会医学**：研究社会因素与健康及疾病之间相互联系及其规律的一门交叉学科，从社会宏观视角研究社会因素对人群健康的影响，探讨保障人群健康的社会策略和方法。
2. **大卫生观**：健康不仅是卫生部门的责任，需要全社会参与和跨部门协作，将健康纳入所有政策领域的宏观卫生理念。

3. **HiAP**：指在制定所有公共政策时系统性地考虑其对健康的影响，明确责任并加强跨部门合作，旨在改善人群健康和健康公平。

三、简答题

1. **研究对象**：社会人群的健康。**研究内容**三大方面：研究社会卫生状况（人群健康状况评价）；研究影响人群健康的因素（特别是社会因素）；研究社会卫生策略与措施。
2. **五大任务**：倡导积极的健康观；发现和评价社会卫生问题；揭示社会因素与健康的因果关系；制定社会卫生策略和措施；培养社会医学专业人才。
3. **特色理论**：社会健康观、社会因素决定论、健康公平理论、整体健康观、大卫生观、健康社会决定因素理论。
4. **重要阶段**：古代：中医“天人合一”整体观；近代：陈志潜定县模式（1941 年）；新中国成立后：爱国卫生运动；改革开放后：1984 年首部教材出版；21 世纪：健康中国战略实施。

本章导览：掌握医学模式的概念及各种医学模式的基本观点；重点掌握生物-心理-社会医学模式的概念、基本内涵及其意义（**教学难点**）；理解健康观的演变和健康与疾病概念的扩展。

2.1 医学模式的概念

[概念] 概念释义：医学模式（Medical Model）：指人们在观察和处理健康与疾病问题的实践中形成的**总体认识框架和基本观点**。它反映了特定历史时期医学科学发展的整体水平、医学思维方式和对健康与疾病问题的基本认知方式，是人类与疾病作斗争、获取健康经验的总结。医学模式是**医学实践活动的指导思想**，影响和决定着医学教育、医学研究、临床诊疗和卫生服务的方向与模式。

[提示] 要点提示：医学模式的核心内容包括三个方面：

1. 疾病观——对疾病本质、原因和机制的基本认识
2. 健康观——对健康本质和标准的认识
3. 医学观——对医学目的、任务和方法的总体看法

2.2 医学模式的演变过程

2.2.1 神灵主义医学模式

[概念] 概念释义：神灵主义医学模式（Spiritualistic Medical Model）：原始社会中，人们将健康与疾病归因于**超自然力量**（神灵、鬼怪等），认为疾病是神灵惩罚或邪魔附体所致，健康是神灵赐福。对疾病的治疗主要依靠巫术、祈祷等驱鬼降神手段。

基本观点：

- 疾病 = 超自然力量的惩罚
- 治疗 = 巫术、祈祷、驱魔
- 医巫不分，健康与疾病被神秘化

2.2.2 自然哲学医学模式

[概念] 概念释义：自然哲学医学模式（Natural Philosophical Medical Model）：古代文明时期，人们开始用**自然哲学思想**来解释健康与疾病现象，将人体视为自然界的缩影，强调人与环境的和谐统一。

基本观点与代表：

1. **古希腊希波克拉底**——体液学说（四体液：血液、黏液、黄胆汁、黑胆汁），四种体液平衡即为健康。强调环境和生活方式对健康的影响，《空气、水与地域》阐述了环境与疾病的关系
2. **中国《黄帝内经》**——阴阳五行学说、天人合一思想。强调情志、饮食、起居、劳逸等对健康的影响，提出“上工治未病”的预防思想
3. **古印度**——三体液学说（气、胆、痰）

！重点掌握：自然哲学医学模式的核心特点：

- **整体观：**人体是一个整体，人与自然也是一个整体
- **平衡观：**健康是体内各要素的平衡，疾病是失衡
- 从自然哲学角度解释疾病，摆脱了纯粹的神灵迷信
- 开始重视环境、生活方式等因素对健康的影响

2.2.3 机械论医学模式

[概念] 概念释义：机械论医学模式（Mechanistic Medical Model）：文艺复兴后，随着物理学和机械力学的兴起，人们将人体视为一部**精密的机器**，疾病是机器零件损坏或功能失常，医生的任务是修理机器。

基本观点：

- 人体 = 精密的机器（心脏 = 泵、关节 = 杠杆、肺 = 风箱）
- 疾病 = 机器部件损坏
- 治疗 = 修复损坏的部件
- 代表：笛卡尔（“动物是机器”）、拉美特利（“人是机器”）

历史贡献与局限：

- 贡献：推动了实验医学和解剖学的发展，使医学摆脱了思辨哲学的束缚
- 局限：忽视了人体生命的复杂性和整体性；忽视了心理、社会因素的作用；将复杂的生命活动简化为机械运动

2.2.4 生物医学模式

[概念] 概念释义：生物医学模式（Biomedical Model）：以**生物学为基础**，从生物学角度认识和解释健康与疾病的医学模式。认为任何疾病都可以在器官、组织、细胞或分子水平上找到生物学的异常改变，每种疾病都可以找到特定的生物学病因和发病机制。

！重点掌握：生物医学模式的基本观点（理论基础）：

1. **病因学一元论：**每种疾病都有特定的生物或理化致病因子（病原体、毒素、理化因素等）
2. **器官定位论：**疾病定位于特定的器官、组织或细胞
3. **特异性治疗论：**针对特定病因采用特异性治疗方法
4. **还原论：**复杂的生命现象可以还原为物理、化学过程来解释
5. **心身二元论：**将躯体与精神分离，忽视心理因素的致病作用

[提示] 要点提示：生物医学模式的历史贡献：

1. 推动了现代医学的巨大进步——微生物学（科赫法则）、免疫学、麻醉、消毒技术、抗生素等的发现和应用
2. 在传染病和急性病的防治中取得了辉煌成就，显著降低死亡率和发病率
3. 建立了科学的疾病分类体系和诊断治疗方法
4. 促进了医学的专科化和精细化发展

生物医学模式的局限性：

1. 忽视了心理、社会因素在疾病发生发展中的作用
2. 将人简单还原为生物学个体，忽视了人的社会属性
3. 无法解释现代疾病谱的变化——慢性非传染性疾病、心身疾病等
4. 过度依赖技术和药物，导致医疗费用不断攀升
5. 忽视预防和健康促进的作用
6. 无法解释一些功能性疾病的病因

2.3 生物-心理-社会医学模式

2.3.1 产生的背景

！重点掌握：生物-心理-社会医学模式产生的四大背景：

1. **疾病谱和死因谱的转变**——从传染病为主转向慢性非传染性疾病（心脑血管病、恶性肿瘤、糖尿病等）为主。这些疾病的病因中，行为生活方式、环境、社会因素占重要地位
2. **对健康需求的提高**——人们不再满足于不生病，而是追求身体、心理和社会的完好状态
3. **医学科学的发展**——心理学、社会学、人类学等与医学的交叉融合，心身医学、行为医学的发展
4. **健康社会决定因素的认知**——大量研究证据表明社会因素对健康的影响至关重要

医学模式转变的流行病学证据：

- 美国：前 10 位死因中，行为生活方式因素占 50% 以上，环境因素占 20%，生物学因素占 20%，卫生服务仅占 10%
- 中国：随着经济发展和老龄化，慢性病负担日益加重，危险因素以行为生活方式和社会环境因素为主

2.3.2 恩格斯的生物-心理-社会医学模式

[概念] 概念释义：Engel 的生物-心理-社会医学模式（Bio-Psycho-Social Medical Model, 1977）：由美国罗切斯特大学精神病学和内科学教授 G.L. Engel 在《科学》杂志上发表论文正式提出。该模式认为，**健康与疾病是生物、心理和社会因素相互作用的结果**，要全面认识健康和疾病，必须考虑生物、心理和社会三个层面的因素及其相互作用。

！重点掌握：（教学难点 *）生物-心理-社会医学模式的基本内涵：

1. **多层次系统论**：人体是一个多层次的等级系统，从分子 → 细胞 → 组织 → 器官 → 系统 → 个体 → 家庭 → 社区 → 社会，每一层次既有其自身的特点和规律，又受上一层和下一层的影响。健康与疾病是各层次因素相互作用的结果。
2. **三维健康决定论**：健康与疾病同时受生物因素（遗传、病原体、生理功能等）、心理因素（认知、情绪、人格、压力等）和社会因素（经济、文化、制度、环境等）三个维度的影响，三个维度相互交织、互为因果。
3. **整体论**：人是一个完整的系统，不能还原为各个部分的简单叠加。医生需要将病人视为一个“完整的人”，而非仅仅是某种疾病的载体。
4. **患者中心论**：医疗服务应以患者为中心，关注患者的主观体验、心理状态和社会处境，而非仅关注疾病的客观指标。

[概念] 概念释义：环境健康医学模式（Blum's Model, 1974）：由 Blum 提出，将影响健康的因素归纳为四大类：**环境因素、行为生活方式、生物遗传因素和医疗卫生服务**。其中**环境因素是最重要的健康决定因素**。

综合健康医学模式（Lalonde-Dever 模型）：在 Blum 模型基础上的进一步发展，将影响健康的因素分为：人类生物学；环境；生活方式；卫生保健体系。

2.3.3 生物-心理-社会医学模式的意义

！重点掌握：生物-心理-社会医学模式的实践意义：

1. **更新医学观念**——促进健康观的更新，从“没有疾病”扩展到“躯体、心理和社会适应的完好状态”
2. **推动医学教育改革**——医学教育从单纯生物学向生物-心理-社会综合知识体系转变，加强人文社会科学教育
3. **改变医疗服务模式**——从“以疾病为中心”转向“以患者为中心”，重视医患沟通、心理关怀和社会支持
4. **促进预防医学发展**——从“三级预防”发展为更加重视“零级预防”和社会预防
5. **推动卫生服务体系改革**——加强初级卫生保健、社区卫生服务和全科医学发展
6. **促进跨学科合作**——医学与心理学、社会学、经济学、管理学等学科的交叉融合
7. **指导卫生政策制定**——强调多部门协作和社会参与，影响“将健康融入所有政策”的理念

2.4 健康观的演变

2.4.1 消极健康观

[概念] 概念释义：消极健康观（经典健康观）：将健康定义为“没有疾病”（Health is the absence of disease）。这种观点以疾病的生物学异常为参照，健康仅仅被理解为非疾病状态。

消极健康观的特点与局限：

- 以疾病为中心定义健康，标准明确但过于狭窄
- 忽视了健康的多维度性（心理、社会维度）
- 无法涵盖亚健康状态和功能健康
- 与“生物医学模式”相适应

2.4.2 WHO 健康观

！重点掌握：世界卫生组织（WHO, 1948）的健康定义：

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity."

健康不仅是躯体没有疾病或虚弱，而且是身体、心理和社会适应的完好状态。

WHO 健康定义的深远意义：

1. 首次提出**三维健康观**——突破了“没有疾病 = 健康”的传统观念
2. 强调**社会维度**——社会适应良好是健康的重要组成部分
3. 将健康从“**消极**”定义转向“**积极**”定义
4. 蕴含**积极健康观**的理念——健康是积极追求的理想状态
5. 为新医学模式（生物-心理-社会医学模式）提供了理论基础
6. 推动医疗服务从“治病”转向“促进健康”

2.4.3 健康与疾病概念的扩展

[概念] 概念释义：疾病（Disease）、病患（Illness）与患病（Sickness）的区分：

- **Disease（疾病）**：医学上客观存在的病理生理学异常，可通过检查诊断确认，是**生物学层面的异常**
- **Illness（病患）**：患者主观感受到的不适、痛苦和功能受限等体验，是**心理学层面的感受**
- **Sickness（患病）**：社会对个体疾病状态的认可和反应，涉及社会角色、权利和义务，是**社会学层面的状态**

现代健康观的多维视角

1. **躯体健康**：身体结构完整、生理功能正常
2. **心理健康**：认知功能正常、情绪稳定、人格健全、良好的应对能力
3. **社会适应良好**：能有效扮演社会角色、维持良好的人际关系和社会功能
4. **道德健康**：行为符合社会道德规范，具有社会责任感和道德判断力
5. **亚健康状态**：介于健康与疾病之间的中间状态，表现为功能减退但无明显器质性病变

2.5 复习题

一、选择题

1. 生物-心理-社会医学模式的提出者是：
(A) Virchow
(B) Blum
(C) Engel
(D) Lalonde
2. 以下哪种医学模式将人体视为“机器”？
(A) 神灵主义医学模式
(B) 自然哲学医学模式
(C) 机械论医学模式
(D) 生物医学模式
3. WHO 健康定义的时间是：

- (A) 1946 年
 - (B) 1948 年
 - (C) 1977 年
 - (D) 1978 年
4. 影响健康的环境因素中, Blum 模型认为最重要因素是:
- (A) 生物遗传因素
 - (B) 行为生活方式
 - (C) 环境因素
 - (D) 医疗卫生服务
5. 以下属于 Disease (疾病) 定义的是:
- (A) 患者主观感受的不适
 - (B) 客观的病理生理学异常
 - (C) 社会对疾病状态的认可
 - (D) 社会角色功能障碍

二、名词解释

1. 医学模式 (Medical Model)
2. 生物-心理-社会医学模式
3. 生物医学模式
4. 健康 (WHO, 1948 定义)

三、简答题

1. 简述生物-心理-社会医学模式产生的背景。
2. 试述生物-心理-社会医学模式的基本内涵及其意义。
3. 简述生物医学模式的基本观点及其局限性。
4. 试述 Disease、Illness、Sickness 三者的区别与联系。
5. 简述 WHO 健康定义的内涵和意义。
6. 试论医学模式转变对医疗卫生实践的影响。

参考答案要点

一、选择题

1. (C); 2. (C); 3. (B); 4. (C); 5. (B)

二、名词解释

1. **医学模式:** 人们在观察和处理健康与疾病问题实践中形成的总体认识框架和基本观点, 是医学实践活动的指导思想。
2. **生物-心理-社会医学模式:** Engel 于 1977 年提出, 认为健康与疾病是生物、心理和社会因素相互作用的结果, 需从三个层面全面认识健康和疾病。
3. **生物医学模式:** 以生物学为基础, 认为任何疾病都可在器官、组织、细胞或分子水平找到生物学异常改变的医学模式。
4. **健康 (WHO):** 健康不仅是躯体没有疾病或虚弱, 而且是身体、心理和社会适应的完好状态 (1948 年 WHO 宪章)。

三、简答题

1. 四大背景: 疾病谱和死因谱转变 (慢性病为主); 健康需求提高 (从“不生病”到“完好状态”); 医学科学发展 (交叉融合); 健康社会决定因素认知 (证据积累)。
2. 基本内涵: 多层次系统论; 三维健康决定论; 整体论; 患者中心论。意义: 更新医学观念、推动教育改革、改变服务模式、促进预防、推动体系改革等。
3. 五大基本观点: 病因学一元论、器官定位论、特异性治疗论、还原论、心身二元论。局限: 忽视心理社会因素、无法解释疾病谱变化、过度依赖技术。
4. Disease 是客观病理生理学异常 (生物学层面), Illness 是患者主观感受 (心理学层面), Sickness 是社会角色状态 (社会学层面)。三者既有区别又相互关联。

5. WHO 定义包括躯体、心理、社会三维完好状态。意义：突破传统消极健康观，为生物-心理-社会医学模式提供理论基础。
6. 从生物医学向生物-心理-社会医学的转变体现在：观念更新、教育变革、服务模式改变、预防策略调整等方面。

By greedyCat

本章导览：掌握健康社会决定因素的概念和理论模型（**教学难点**）；理解社会因素影响健康的规律与特点；了解健康社会决定因素的发展历程、行动框架及“将健康融入所有政策”的理念与实践。

3.1 社会因素概述

[概念] 概念释义：社会因素（**Social Factor**）：指社会的各项构成要素，包括**社会环境、社会经济、社会制度、社会文化、社会行为、卫生服务**等，是影响人群健康的重要因素。

社会因素的内容：

- 社会经济因素——经济发展水平、收入、贫困等
- 社会环境因素——人口、营养、城市化、社会支持等
- 社会文化因素——教育、文化、宗教、风俗习惯等
- 行为心理因素——生活方式、心理压力、人格等
- 卫生服务因素——卫生资源配置、服务可及性等
- 社会制度因素——政治体制、社会保障制度等

3.2 健康社会决定因素的概念

[概念] 概念释义：健康社会决定因素（**Social Determinants of Health, SDH**）：**（教学难点*）**指在那些直接导致疾病的因素之外，由人们的社会地位和所拥有资源所决定的生活和工作环境条件，及其对健康产生影响的社会性因素。即“**影响健康影响因素的社会因素**”——决定人们健康水平的“原因的原因”（causes of the causes）。

！重点掌握：理解“原因的原因”：

- 直接病因：如吸烟 → 肺癌（直接因果关系）
- SDH：如低教育水平 → 吸烟率高 → 肺癌（社会因素是直接病因背后的深层原因）
- SDH 关注的是**健康不公平的社会根源**——为什么有些人比其他更容易生病？
- 核心观点：**社会不平等 → 健康不平等**，社会结构性因素决定了人群健康状况的系统性差异

3.3 健康社会决定因素理论的发展

！重点掌握：CSDH（2008）三大行动原则：

1. **改善日常生活条件**——从出生开始改善儿童早期发育；改善居住环境和工作条件；建立全民社会保障制度
2. **改变权力、资金和资源分配的不公平**——将健康公平纳入政府各部门政策；建立公平的筹资机制；增强市场行为的规范性
3. **测量和理解问题并评估行动效果**——建立健全的健康公平监测体系；培训研究人员；扩大公众对 SDH 的认知

表 3.1: 健康社会决定因素理论发展历程

时间	主要事件与发展
19 世纪	Virchow、Engels 等关注社会条件与疾病关系，认为疾病根源在于社会不平等
1948 年	WHO 成立，宪章确立健康权为基本人权，承认社会条件对健康的重要性
1978 年	Alma-Ata 宣言，提出” 人人享有卫生保健” 目标，强调初级卫生保健和社会公平
1980 年代	英国 Black Report（黑报告）揭示社会阶层间健康状况的梯度差异
1990 年代	加拿大、荷兰等国开始系统研究健康的社会决定因素
2003 年	WHO 出版《健康社会决定因素：确凿事实》
2005 年	WHO 成立健康社会决定因素委员会（CSDH）
2008 年	CSDH 发布《用一代人时间弥合差距》最终报告，提出三大行动原则
2009 年	第 62 届世界卫生大会通过决议，推动各国行动
2011 年	《里约政治宣言》进一步确认 SDH 的重要性，提出五大行动领域

3.4 健康社会决定因素的理论模型

3.4.1 Dahlgren 和 Whitehead 模型（1991）

！重点掌握：Dahlgren 和 Whitehead 于 1991 年提出的**彩虹模型**是最经典的健康社会决定因素理论模型，将影响健康的因素分为五个层次：

1. **核心层——个体因素：**年龄、性别、遗传因素（不可改变的个人特征）
2. **第二层——个人生活方式：**吸烟、饮酒、饮食、体力活动等健康相关行为
3. **第三层——社会与社区网络：**家庭支持、朋友网络、社区参与等社会关系因素
4. **第四层——生活与工作条件：**住房、工作环境、教育、医疗服务、水和卫生设施、农业和食物生产、失业等
5. **最外层——宏观社会经济、文化和环境条件：**国家经济政策、社会文化价值观、政治制度、全球化等

该模型强调：**从内到外的影响路径**——外层因素通过影响内层因素最终影响个体健康；**从外到内的决定路径**——越外层的因素影响力越广泛深远。

3.4.2 WHO 的 SDH 行动框架

[概念] 概念释义：WHO 健康社会决定因素委员会（CSDH）行动框架将影响健康的社会因素分为两大类：

1. **结构性决定因素（Structural Determinants）：**社会经济和政治环境（社会治理、经济政策、社会政策、公共政策、文化和社会价值观）与社会经济地位（收入、教育、职业、社会阶层、性别、种族/民族）
2. **中介决定因素（Intermediary Determinants）：**物质环境（住房、居住环境、工作环境等）、社会心理环境（社会支持、压力等）、行为和生物因素、卫生系统

3.5 影响健康的主要社会因素

3.5.1 社会因素影响健康的规律与特点

！重点掌握：社会因素影响健康的五大特点：

1. **非特异性：**社会因素对健康的影响往往是广泛而非特异性的。同一社会因素可影响多种健康结局（如贫困可增加多种疾病的发病率和死亡率）
2. **交互作用：**各种社会因素之间相互影响、相互制约，共同作用于人群健康。社会经济、文化、行为因素之间存在复杂的交互效应
3. **累积效应：**社会因素对健康的影响往往具有长期累积效应。如生命历程中不同阶段的社会经济劣势可累积为成年后的健康损害
4. **广泛性和持久性：**社会因素影响整个人群，其作用持久而深远，往往跨越一代人
5. **双向性：**社会因素与健康之间存在双向关系——不良社会条件损害健康，而健康损害又会加剧社会劣势，形成恶性循环

3.5.2 主要社会因素

影响健康的主要社会因素

1. **社会经济因素**：收入水平、贫富差距、经济发展阶段、就业状况、职业类型等
2. **社会制度因素**：政治体制、法律制度、社会保障制度、医疗卫生制度等
3. **社会文化因素**：教育水平、文化传统、价值观念、道德规范、宗教信仰等
4. **社会人口因素**：人口数量、结构、素质、流动与迁移等
5. **社会关系因素**：家庭关系、社会支持网络、社区参与、社会资本等
6. **社会行为因素**：健康相关行为、生活方式、吸烟、饮酒、饮食、运动等
7. **卫生服务因素**：卫生资源的配置、质量、可及性和利用等
8. **环境因素**：自然环境（空气、水、土壤）、建成环境（住房、交通、绿地）等

3.6 将健康融入所有政策

[概念] 概念释义：将健康融入所有政策（Health in All Policies, HiAP）：由 WHO 倡导，指在制定所有公共政策和决策时，系统性地、明确地考虑其对人群健康的影响，明确跨部门责任，加强部门协作，以实现改善人群健康和健康公平的目标。

！重点掌握：HiAP 的核心理念：

1. 健康不仅是卫生部门的职责，政府部门的所有决策都可能影响健康
2. 需要跨部门合作和政府高层领导的承诺
3. 政策制定应考虑对健康的长远影响和在不同人群中的分布
4. 实现健康公平是社会正义的体现

HiAP 的实践领域（WHO, 2014 年提出 6 个关键组成部分）：

1. 确定 HiAP 的需求和优先领域
2. 建立必要的组织框架和行动计划
3. 建立支持性的机制和流程
4. 增强跨部门协作的能力
5. 确保监测、评估和报告
6. 加强培训和能力建设

[提示] 要点提示：中国 HiAP 实践：

- 2013 年国家卫生计生委发布《“健康中国”战略规划》
- 2016 年《“健康中国 2030”规划纲要》将“将健康融入所有政策”确立为核心理念
- 爱国卫生运动是 HiAP 在中国的早期实践——多部门参与、全社会动员
- 健康影响评价制度正在逐步建立和完善

3.7 复习题

一、选择题

1. 健康社会决定因素（SDH）的核心观点是：
(A) 遗传因素是健康的最主要决定因素
(B) 社会结构性因素是健康不公平的根源
(C) 个人行为是健康的唯一决定因素
(D) 医疗技术水平决定人群健康水平
2. Dahlgren 和 Whitehead 的彩虹模型中，最外层影响因素是：
(A) 个人生活方式
(B) 社会与社区网络
(C) 生活与工作条件
(D) 宏观社会经济、文化和环境条件
3. WHO 成立 CSDH（健康社会决定因素委员会）的时间是：

- (A) 2003 年
 - (B) 2005 年
 - (C) 2008 年
 - (D) 2011 年
4. 社会因素影响健康的特点不包括：
- (A) 非特异性
 - (B) 高度的特异性
 - (C) 交互作用
 - (D) 累积效应
5. HiAP 的含义是：
- (A) 健康城市项目
 - (B) 全民健康覆盖
 - (C) 将健康融入所有政策
 - (D) 初级卫生保健

二、名词解释

1. 健康社会决定因素（SDH）
2. 将健康融入所有政策（HiAP）
3. 结构性决定因素与中介决定因素

三、简答题

1. 简述社会因素影响健康的规律与特点。
2. 简述 Dahlgren 和 Whitehead 彩虹模型的主要内容。
3. 试述 CSDH 三大行动原则。
4. 简述 HiAP 的核心理念和实践意义。

参考答案要点

一、选择题

1. (B)；2. (D)；3. (B)；4. (B)；5. (C)

二、名词解释

1. **SDH**：由人们社会地位和资源所决定的生活与工作环境条件及其对健康产生影响的社会性因素，即“原因的原因”。
2. **HiAP**：在制定所有公共政策时系统性地考虑其对健康的影响，加强跨部门协作，改善人群健康和健康公平。
3. **结构性决定因素**：社会经济政治环境和社会经济地位（治理、政策、文化价值观与收入、教育、职业等）。
中介决定因素：物质环境、社会心理环境、行为和生物因素、卫生系统。

三、简答题

1. 五大特点：非特异性、交互作用、累积效应、广泛性和持久性、双向性。社会因素影响力广泛深远，需要从多维度系统分析其健康效应。
2. 五层结构：个体因素（年龄、性别、遗传）；个人生活方式；社会与社区网络；生活与工作条件；宏观社会经济文化环境。外层通过影响内层最终影响个体健康。
3. 改善日常生活条件（从出生开始改善儿童早期发育、改善居住工作条件、建立全民社保）；改变权力、资金和资源分配不公（健康公平融入各部门政策、公平筹资机制）；测量理解问题并评估行动（建立监测体系、扩大公众认知）。
4. 核心理念：健康不仅是卫生部门职责，需要跨部门合作；政策应考虑对健康长远影响和人群分布差异；实现健康公平是社会正义体现。

本章导览：掌握经济发展水平与健康的双向作用（**教学难点**）；熟悉经济发展水平和健康的衡量指标；理解健康投资的内涵及效益分析；了解经济发展与卫生服务的关系。

4.1 经济发展水平的衡量指标

4.1.1 宏观经济指标

[概念] 概念释义：国内生产总值（Gross Domestic Product, GDP）：在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值总和。是衡量国家经济状况的最常用指标。

国民生产总值（Gross National Product, GNP）：一个国家（或地区）所有国民在一定时期内生产的最终产品和劳务的价值总和。 $GNP = GDP + \text{来自国外的净要素收入}$ 。

4.1.2 综合发展指标

主要综合发展指标

1. 人类发展指数（Human Development Index, HDI）：联合国开发计划署（UNDP）1990 年提出，综合反映国家社会经济发展水平。包括三个维度：

- 健康长寿——以出生时预期寿命衡量
- 教育获得——以成人识字率和综合入学率衡量
- 生活水平——以人均 GDP（购买力平价 PPP）衡量

HDI 值 0–1， ≥ 0.800 为极高人类发展水平， $0.700\text{--}0.799$ 为高， $0.550\text{--}0.699$ 为中等， < 0.550 为低

2. 物质生活质量指数（Physical Quality of Life Index, PQLI）：由婴儿死亡率、1 岁期望寿命和识字率三项指标综合而成，用于衡量穷国贫民生活状况

3. 真实进步指标（Genuine Progress Indicator, GPI）：在 GDP 基础上调整环境成本和社会代价，更真实地反映经济福利水平

4. 国民幸福指数（National Happiness Index, NHI）：综合测量国民对生活满意程度的主观感受

5. 全球幸福指数（Global Happiness Index, GHI）：联合国发布的各国居民幸福程度排名指数

4.2 健康的衡量指标

表 4.1: 常用健康衡量指标	
指标类型	具体指标
人口统计指标	出生率、死亡率、婴儿死亡率（IMR）、孕产妇死亡率（MMR）、期望寿命
疾病统计指标	发病率（Incidence Rate）、患病率（Prevalence Rate）
综合健康指标	健康期望寿命（HALE）、伤残调整寿命年（DALYs）、质量调整寿命年（QALYs）
卫生服务指标	卫生总费用（THE）及其占 GDP 比重、人均卫生费用

！重点掌握：婴儿死亡率（IMR）是反映一个国家或地区社会经济和卫生发展水平的**最敏感指标**之一，也是衡量人群健康状况的核心指标。

期望寿命（Life Expectancy）是评价人群健康状况和社会发展水平的综合性指标。

卫生总费用（Total Health Expenditure, THE）：一个国家或地区在一定时期内全社会用于卫生保健支出的货币总和，包括政府卫生支出、社会卫生支出和居民个人现金卫生支出。

4.3 经济发展水平与健康的双向作用

4.3.1 经济发展对健康的促进作用

！重点掌握：（教学难点*）经济发展促进健康的途径：

1. **改善物质生活条件**——提高人们的收入水平，改善营养、住房、衣着等基本生活条件
2. **增加卫生投入**——经济发展 → 政府财政收入增加 → 公共财政中卫生支出增加 → 卫生基础设施改善
3. **提高教育水平**——教育水平的普遍提高增强人们的健康意识和卫生知识，促进健康行为的形成
4. **完善社会保障**——建立和完善医疗保险、养老、工伤、失业等社会保障制度
5. **改善环境卫生**——安全饮水、卫生厕所、垃圾处理等环境卫生条件的改善

经济发展与健康关系的一般规律：经济发展水平越高的国家，期望寿命越长，婴儿死亡率越低，传染病发病率越低。但同时，慢性非传染性疾病、精神疾患和伤害的比例随经济发展而升高。

4.3.2 经济发展对健康的负面效应

！重点掌握：经济发展对健康的不良影响：

1. **环境污染与生态破坏**——工业化带来空气、水、土壤污染；气候变化和生物多样性减少对健康构成长期威胁
2. **不良行为生活方式的增加**——高热量饮食、体力活动减少、吸烟、酗酒等与经济发展伴随的不良生活方式
3. **心理健康问题的增加**——竞争加剧、生活节奏加快、社会关系疏离导致心理压力增大，抑郁症和焦虑症等精神疾病增加
4. **职业健康危害**——工伤、职业病、职业压力等与生产活动相关的健康问题
5. **社会不平等加剧**——贫富差距扩大直接导致健康不公平；相对剥夺感对低收入群体心理健康的损害
6. **交通事故和伤害增加**——机动车数量增加导致交通事故伤害增多
7. **传染病流行风险**——经济全球化增加新发传染病跨国传播的风险（如 COVID-19 大流行）
8. **食品安全问题**——食品工业化生产带来食品安全隐患

4.3.3 健康对经济发展的促进作用

！重点掌握：健康促进经济发展的路径：

1. **提高劳动生产率**——健康的劳动力具有更高的工作效率和更低的缺勤率
2. **增加教育投资回报**——健康的儿童学习能力更强，教育投资回报率更高
3. **增加劳动力供给**——更长的健康寿命延长了劳动力参与时间
4. **减少疾病经济负担**——预防疾病减少直接医疗费用支出和间接生产力损失
5. **促进储蓄和投资**——健康人群更有可能进行长期储蓄和生产性投资
6. **释放“人口红利”**——健康水平提高是人口红利转化为经济增长红利的前提条件

表 4.2: 经济发展与健康关系的国际比较					
国家类型	人均 GNI (美元)	IMR (‰)	MMR (/10万)	期望寿命 (岁)	THE 占 GDP (%)
低收入国家	约 600-3000	30-90	200-500	60-68	4-6
中等收入国家	约 3000-12000	10-30	50-200	68-76	5-8
高收入国家	>12000	3-10	<50	78-84	8-12

4.3.4 经济发展与健康的双向作用总结

！重点掌握：经济发展与健康的关系并非简单的线性关系：

1. 总体上呈**正相关**——经济发展水平越高，人群健康水平越高
2. 关系呈**边际递减效应**——经济发展在较低水平时对健康的促进作用最显著，达到一定水平后促进作用减弱
3. 存在“**双刃剑**”效应——经济发展既带来健康红利，也带来新的健康风险
4. 需要**政策引导**——通过社会政策调节经济发展对健康的影响，将健康红利最大化，健康风险最小化

4.4 健康投资

[概念] 概念释义：健康投资（Health Investment）：为保护和增进人群健康而投入的各种资源，包括**人、财、物、时间、信息**等。健康投资不仅包括对医疗卫生服务的直接投入，还包括为提高健康水平而进行的社会性投入（教育、环境保护、住房改善等）。

4.4.1 健康投资的内涵

1. **卫生服务投资：**对医疗卫生机构、设备、人员、技术等投入
2. **公共卫生投资：**疾病预防控制、健康教育、环境卫生等投入
3. **社会性健康投资：**教育、营养改善、住房改善、安全饮水、社会保障等间接促进健康的投入
4. **个人健康投资：**个人为维护健康所投入的时间、金钱和精力

4.4.2 健康投资效益分析

[概念] 概念释义：健康投资的效益可从微观（个人/家庭）和宏观（社会/国家）两个层面理解：

- **微观效益：**减少个人医疗支出、减少因病收入损失、提高个人劳动生产力、提高终身收入
- **宏观效益：**减少社会疾病经济负担、提高人力资本质量和数量、促进经济持续增长、减少贫困、促进社会公平

！重点掌握：健康投资的经济学意义：

1. 健康是**人力资本**的重要组成部分，健康投资是人力资本投资的核心内容
2. 健康投资具有**高回报率**——据 WHO 估算，每投入 1 美元用于健康改善，可获得 2-4 美元的回报
3. 健康投资是**经济可持续发展的基础**，“健康中国 2030”战略明确了健康在经济社会发展中的优先地位
4. 预防性健康投资（公共卫生、健康教育等）的**成本效益比最高**
5. 卫生总费用（THE）占 GDP 的比重是衡量一个国家或地区健康投资水平的重要指标

4.5 复习题

一、选择题

1. 衡量一个国家或地区社会经济和卫生发展水平最敏感的指标是：
(A) GDP
(B) 期望寿命
(C) 婴儿死亡率
(D) 成人识字率
2. HDI（人类发展指数）不包括以下哪个维度？
(A) 健康长寿
(B) 教育获得
(C) 政治民主
(D) 生活水平
3. 经济发展对健康的“双刃剑”效应是指：
(A) 经济发展总是促进健康
(B) 经济发展总是损害健康

- (C) 经济发展既有促进健康的作用，也带来新的健康风险
(D) 经济发展与健康无关
4. 健康投资中成本效益比最高的是：
- (A) 高精尖医疗设备投入
(B) 三级医院建设
(C) 预防性健康投资
(D) 药品研发投入

二、名词解释

1. 健康投资 (Health Investment)
2. 国内生产总值 (GDP)
3. 人类发展指数 (HDI)

三、简答题

1. 试述经济发展水平与健康的双向作用机制。
2. 简述经济发展对健康可能产生的负面影响。
3. 简述健康投资的内涵及其效益。
4. 为什么说健康是人力资本的重要组成部分？

参考答案要点

一、选择题

1. (C)；2. (C)；3. (C)；4. (C)

二、名词解释

1. **健康投资**：为保护和增进人群健康而投入的各种资源（人、财、物、时间、信息等），包括卫生服务投资和间接的社会性健康投入。
2. **GDP**：一个国家或地区在一定时期内生产的全部最终产品和劳务的价值总和，是衡量国家经济状况最常用的指标。
3. **HDI**：UNDP 于 1990 年提出的综合反映国家社会经济发展水平的指标，包括预期寿命、教育获得和生活水平三个维度。

三、简答题

1. **经济 → 健康**：促进方面——改善物质生活、增加卫生投入、提高教育水平、完善社会保障；负面方面——环境污染、不良生活方式、心理压力增加、社会不平等加剧。**健康 → 经济**：提高劳动生产率、增加教育投资回报、减少疾病负担、促进储蓄和投资。
2. 七大负面影响：环境污染与生态破坏、不良行为生活方式增加、心理健康问题增加、职业健康危害、社会不平等加剧、交通事故增加、传染病流行风险和新发传染病。
3. **内涵**：卫生服务投资、公共卫生投资、社会性健康投资、个人健康投资。**效益**：微观层面——减少个人医疗支出、提高生产力；宏观层面——减少疾病经济负担、促进经济增长、促进社会公平。
4. 健康是人力资本的核心要素：健康的劳动力具有更高的效率；健康的儿童学习能力更强；更长的健康寿命延长了劳动力参与时间；健康投资具有高回报率（每 1 美元投入回报 2-4 美元）。

本章导览：掌握人口结构与健康、人口流动与健康的关系（**教学难点**）；掌握社会支持的概念及类型；熟悉食品安全概念及防治、家庭对健康的影响；理解社会阶层与健康的关系；了解人口数量、营养、体力活动、城市化等因素的健康影响。

5.1 人口与健康

5.1.1 人口数量与健康

[概念] 概念释义：人口数量与健康的关系：

- 人口过多 → 资源（粮食、水、能源）紧张 → 营养不良、环境污染、居住拥挤 → 传染病易于传播
- 人口过少 → 劳动力不足 → 经济发展受限 → 卫生投入不足
- **人口密度**过高增加传染病传播风险和心理压力
- 世界人口持续增长对全球卫生系统构成持续性压力

5.1.2 人口结构与健康（**教学难点 ***）

！重点掌握：（**教学难点 ***）人口年龄结构与健康：

1. 年龄结构类型：

- 年轻型（增长型）——0-14 岁人口占比 $\geq 40\%$ ，65 岁及以上 $\leq 4\%$
- 成年型（稳定型）——0-14 岁占 30-40%，65 岁及以上占 4-7%
- 老年型（缩减型）——0-14 岁 $\leq 30\%$ ，65 岁及以上 $\geq 7\%$

2. **人口老龄化：**60 岁以上人口占总人口比例 $\geq 10\%$ 或 65 岁以上 $\geq 7\%$ 即为老龄化社会

3. 老龄化的健康影响：

- 慢性非传染性疾病负担加重（心脑血管病、肿瘤、糖尿病等）
- 老年综合征（跌倒、失能、痴呆、抑郁等）增加
- 长期照护需求急剧增长
- 社会保障和医疗卫生系统压力增大

4. **抚养系数：**

- 总抚养系数 = $[(14 \text{ 岁及以下人口数} + 65 \text{ 岁及以上人口数}) / 15-64 \text{ 岁人口数}] \times 100\%$
- 少儿抚养系数 = $(14 \text{ 岁及以下人口数} / 15-64 \text{ 岁人口数}) \times 100\%$
- 老年抚养系数 = $(65 \text{ 岁及以上人口数} / 15-64 \text{ 岁人口数}) \times 100\%$

5. **性别结构：**出生性别比 = $(\text{某年活产男婴数} / \text{同年活产女婴数}) \times 100$ ，正常范围为 103-107。性别比失调会带来一系列社会健康和稳定问题

5.1.3 人口素质与健康

[概念] 概念释义：人口素质包括三个方面：

1. **思想道德素质**
2. **科学文化素质**——受教育水平直接影响健康知识获取和健康行为养成
3. **身体素质**——包括体格发育、生理机能、智力水平等，与遗传、营养、环境有关

出生缺陷是影响人口素质的重要因素——我国出生缺陷发生率约为 5.6%，是婴儿死亡和儿童残疾的首要原因，带来沉重的社会疾病负担。

5.1.4 人口流动与健康（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）人口流动对健康的影响：

流动人口面临的主要健康问题：

1. **传染病传播风险：**流动人口密集的生活和工作条件有利于传染病的传播（结核病、性传播疾病、艾滋病等）
2. **职业健康危害：**多从事高风险职业（建筑、采矿、制造业等），职业伤害和职业病发病率高
3. **妇幼健康问题：**流动妇女产前检查率低、住院分娩率低，新生儿和婴儿死亡率较高
4. **心理健康问题：**社会隔离、歧视、工作压力、家庭分离等导致心理问题
5. **卫生服务可及性差：**医疗保险关系转移接续困难，经济负担重，就医不便
6. **儿童健康与发展：**留守儿童和流动儿童的健康、营养、心理和教育问题突出
7. **”输入性”传染病风险：**某些地区性传染病可能随人口流动传播到新地区

5.2 营养、食品安全与健康

5.2.1 营养与健康

1. **营养不良**——包括营养不足（消瘦、发育迟缓、微量营养素缺乏）和营养过剩（超重、肥胖）。我国面临营养不良的**双重负担**
2. **营养过剩**——导致肥胖、2型糖尿病、心血管疾病、某些癌症的风险增加
3. **膳食结构不合理**——高盐、高脂、低蔬菜水果摄入增加慢性病风险

5.2.2 食品安全

[概念] 概念释义：食品安全（Food Safety）：指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。

！重点掌握：食品安全事件的危害：

1. 急性食源性疾病——微生物污染（细菌、病毒）导致食物中毒
2. 慢性健康损害——农药残留、重金属、食品添加剂等长期低剂量暴露
3. 社会恐慌和社会心理影响
4. 经济损失——影响食品产业和国际贸易

食品安全的社会防治：

1. 完善食品安全法律法规和标准体系（《食品安全法》）
2. 建立食品安全全程监管体系——从农田到餐桌
3. 加强食品安全风险监测与评估
4. 提高食品安全检测技术和能力
5. 加强食品安全教育和信息沟通
6. 鼓励社会监督和参与

5.3 体力活动、职业压力与健康

5.3.1 体力活动与健康

1. **缺乏体力活动**已成为全球第四大死亡危险因素
2. 适量体力活动可降低心血管疾病、糖尿病、某些癌症、抑郁症的风险
3. WHO 建议成人每周至少 150 分钟中等强度有氧运动
4. 久坐生活方式（Sedentary Lifestyle）是独立的健康危险因素

5.3.2 职业压力与健康

[概念] 概念释义：职业压力（Occupational Stress）：当工作要求与工作者的能力、资源或需求不匹配时产生的有害的生理和情绪反应。

职业压力的健康影响：心血管疾病、心理障碍（抑郁、焦虑、职业倦怠）、免疫功能下降、肌肉骨骼疾患增加。

5.4 城市化与健康

[概念] 概念释义：城市化（Urbanization）：由农业为主的传统乡村社会向以工业和服务业为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程。

！重点掌握：城市化对健康的影响：

积极影响：

1. 卫生服务可及性更好
2. 教育机会更多 → 健康素养更高
3. 就业机会和收入水平较高
4. 基础设施（供水、排污、交通）改善

消极影响（“城市病”）：

1. 环境污染（空气、噪声、光污染）
2. 生活节奏快、竞争压力大 → 心理问题
3. 慢性病高发（饮食西方化、久坐生活方式）
4. 交通拥堵和交通事故
5. 社会关系疏离 → 社会支持减弱
6. 传染病在密集人口中的传播风险
7. “城市贫民窟”问题——居住条件恶劣、卫生设施缺乏

5.5 社会网络与社会支持

5.5.1 社会网络

[概念] 概念释义：社会网络（Social Network）：个人与其他人之间所有社会联系所构成的网络系统。社会网络以个体为中心，围绕个体的社会关系形成。

- 社会网络的功能：提供社会支持；传递信息和价值观；影响健康行为；提供社会参与机会
- 社会网络的密度、规模、强度和互惠性影响其对健康的保护作用

5.5.2 人际关系与社会支持

[概念] 概念释义：人际关系（Interpersonal Relationship）：人们在社会交往过程中形成的各种关系的总称，包括家庭关系、朋友关系、同事关系、邻里关系等。

！重点掌握：社会支持（Social Support）：个人从社会网络中所获得的物质和精神的帮助与支持。

社会支持的类型：

1. 情感支持（Emotional Support）：提供共情、关心、爱护与信任，帮助个体应对心理压力
2. 物质支持（Instrumental Support）：提供实际的物质帮助和服务（金钱、物品、人力帮助等）
3. 信息支持（Informational Support）：提供有助于解决问题的建议、指导和信息
4. 评价支持（Appraisal Support）：提供反馈、肯定和社会比较，帮助个体进行自我评价

社会支持对健康的影响机制：

1. 直接效应（主效应模型）：良好的社会支持直接促进健康，无论是否处于应激状态
2. 缓冲效应（压力缓冲模型）：社会支持缓冲压力事件对健康的负面冲击
3. 社会支持可改善免疫功能、降低心血管反应性、促进健康行为

5.6 家庭与健康

5.6.1 家庭的类型与功能

[概念] 概念释义：家庭是以婚姻和血缘关系为基础建立起来的社会生活的基本单位。

家庭类型：

- 核心家庭——由父母和未婚子女组成
- 扩展家庭——由两代或两代以上的夫妇及子女组成
- 单亲家庭
- 其他特殊家庭（重组家庭、空巢家庭等）

家庭功能：

1. 生育功能
2. 抚养和赡养功能
3. 经济功能
4. 情感支持功能
5. 社会化功能——价值观、行为规范的内化

5.6.2 家庭对健康的影响

！重点掌握：家庭对健康的积极影响：

1. 提供情感支持——减少心理问题和精神疾病
2. 影响健康行为的形成——饮食、运动、卫生习惯等
3. 在疾病时提供照护
4. 提供经济和物质保障

家庭对健康的消极影响：

1. 家庭暴力——直接躯体伤害和心理创伤
2. 家庭功能失调——增加成员患病风险
3. 家庭压力（离婚、丧偶、经济困难等）——增加心理和躯体疾病风险
4. 家庭中传染病传播（如结核病、肝炎等）

5.7 退休、失业与健康

1. **失业与健康**：失业导致收入下降、社会地位丧失、心理压力增加，与死亡率升高、心理健康问题、自杀风险增加密切相关
2. **退休与健康**：退休是人生重要的角色转换，适应良好者健康不受影响甚至改善，适应不良者可能出现“退休综合征”——抑郁、失落感、躯体不适等

5.8 社会阶层与健康

[概念] 概念释义：社会阶层（Social Class/Social Stratum）：由于经济、政治、社会等多种原因形成的，在社会层次结构中处于不同地位的社会群体。

！重点掌握：社会阶层对健康的影响（健康梯度现象）：

1. **健康梯度（Health Gradient）**：社会阶层每上升一个层级，健康状况和期望寿命均有改善，形成从高到低的梯度关系，而非仅“两极”差异
2. 低社会阶层人群具有更高的死亡率、发病率和更低的期望寿命
3. **影响机制**：
 - 物质路径：收入差异 → 生活条件、营养、医疗可及性差异
 - 心理路径：低社会地位 → 相对剥夺感、失控感 → 慢性应激
 - 行为路径：健康素养差异 → 健康行为差异
 - 生命周期累积：生命历程中社会劣势的累积效应
4. **Wilkinson 假说**：在富裕国家，社会不平等程度（而非平均收入水平）是决定人群健康水平的关键因素

5.9 复习题

一、选择题

1. 衡量人口老龄化最常用的指标是：
(A) 60 岁以上人口 $\geq 10\%$ 或 65 岁以上 $\geq 7\%$
(B) 60 岁以上人口 $\geq 15\%$ 或 65 岁以上 $\geq 10\%$
(C) 50 岁以上人口 $\geq 20\%$
(D) 70 岁以上人口 $\geq 5\%$
2. 社会支持的类型不包括：
(A) 情感支持
(B) 物质支持
(C) 政治支持
(D) 信息支持
3. 以下属于“健康梯度”现象的是：
(A) 只有最贫困和最富有人群的健康存在差异
(B) 社会阶层每上升一级，健康状况均有改善
(C) 社会阶层与健康完全无关
(D) 中产阶级的健康状况最差
4. 正常出生性别比的范围是：
(A) 95-100
(B) 103-107
(C) 110-115
(D) 100-103

二、名词解释

1. 社会支持 (Social Support)
2. 健康梯度 (Health Gradient)
3. 城市化 (Urbanization)
4. 人口老龄化

三、简答题

1. 试述人口流动对健康的影响。
2. 简述社会支持的类型及其对健康的影响机制。
3. 简述社会阶层对健康的影响及可能机制。
4. 简述食品安全的概念及其社会防治措施。
5. 简述城市化对健康的正反两面影响。

参考答案要点

一、选择题

1. (A); 2. (C); 3. (B); 4. (B)

二、名词解释

1. **社会支持**：个人从社会网络中获得物质和精神帮助与支持的总和，包括情感、物质、信息和评价支持四种类型。
2. **健康梯度**：社会阶层与健康水平之间存在的梯度关系，社会阶层每上升一个层级，健康状况均有改善。
3. **城市化**：由农业为主的乡村社会向以工业和服务业为主的现代城市社会转变的过程。
4. **人口老龄化**：60 岁以上人口占总人口比例 $\geq 10\%$ 或 65 岁以上 $\geq 7\%$ 的社会现象。

三、简答题

1. 七大健康问题：传染病传播风险、职业健康危害、妇幼健康问题、心理健康问题、卫生服务可及性差、儿童健康与发展问题、“输入性”传染病风险。

2. 四种类型：情感支持（共情和关爱）、物质支持（实际帮助）、信息支持（建议指导）、评价支持（反馈和比较）。影响机制：直接效应（主效应模型）和缓冲效应（压力缓冲模型）。
3. 健康梯度现象：社会阶层每上升一级，健康均有改善。机制：物质路径（收入和生活条件）、心理路径（相对剥夺感和慢性应激）、行为路径（健康素养和行为差异）、生命周期累积效应。
4. **食品安全**：食品无毒无害、符合营养要求、不造成健康危害。防治措施：完善法规和标准、全程监管体系、风险监测评估、提高检测能力、加强教育沟通、鼓励社会监督。
5. 积极：卫生服务可及性好、教育机会多、收入高、基础设施改善。消极：环境污染、心理压力大、慢性病高发、交通事故、社会关系疏离、“城市贫民窟”问题。

本章导览：掌握文化对人群健康的影响及作用模式（**教学难点**）；熟悉文化的概念、构成与特征；理解教育、风俗习惯、宗教等因素对健康的影响；了解科技进步、道德、非主流文化与健康的关系。

6.1 文化概述

[概念] 概念释义：文化（**Culture**）：广义指人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和；狭义指社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。社会医学主要关注**狭义文化**——包括思想观念、价值体系、道德规范、语言文字、科学技术、宗教、艺术等精神文化要素。

6.1.1 文化的构成

文化构成的三个层次

1. **物质文化**——人类创造的物质产品和技术成果，如工具、建筑、医疗设备等。直接影响人类生活条件和健康水平
2. **制度文化**——社会规范、法律、政治制度、社会组织形式等。通过约束和调节人类行为间接影响健康
3. **精神文化**——思想观念、价值体系、宗教信仰、伦理道德、科学知识、艺术审美等。是文化的核心，深刻影响人们的健康观念和健康行为

6.1.2 文化的特征与类型

！重点掌握：文化的特征：

1. **历史继承性**——文化是历史传承的产物，通过社会化过程代代相传
2. **社会共享性**——文化是社会群体共享的知识和信念体系
3. **适应性**——文化随社会环境变化而演变和调整
4. **民族性和区域性**——不同民族和地区具有不同的文化特性
5. **习得性**——文化不是遗传的，而是后天学习和获得的

文化的类型：

- **主流文化（Mainstream Culture）**：社会中占主导地位的文化
- **亚文化（Subculture）**：某一群体特有的区别于主流文化的文化模式
- **反文化（Counterculture）**：与主流文化价值观念对立的文化
- **跨文化（Cross-culture）**：不同文化背景的人群间的文化比较

6.2 文化对人群健康的影响

6.2.1 文化影响健康的作用模式（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）文化影响健康的四大作用模式：

1. **文化决定健康观念模式：**不同文化下的疾病认知、病因解释和健康信念显著不同，影响人们求医行为和健康管理行为选择。例如：不同文化对“健康”和“疾病”的定义存在差异；不同文化对疼痛、不适的表达方式不同
2. **文化塑造健康行为模式：**饮食文化（西方高脂饮食 vs. 地中海饮食 vs. 东方饮食）、饮酒文化、吸烟文化等直接影响健康。文化价值观和规范通过社会化过程内化为个人的日常行为习惯
3. **文化影响卫生服务利用模式：**传统文化和民间医学影响人们对现代医疗和传统医疗的选择偏好。不同文化群体对精神卫生服务的利用存在显著差异（病耻感、对病因的文化解释等）
4. **文化调节心理应激反应模式：**文化决定应激源的评价方式（什么是“压力”）、应对策略的选择（求助、回避、情绪调节等）和社会支持的可获得性。集体主义文化与个人主义文化在应对方式上存在显著差异

6.2.2 文化影响健康的特点

1. **潜移默化性**——文化对健康的影响往往是不自觉的、渐进的、内在化的
2. **广泛渗透性**——文化影响渗透到日常生活的方方面面，涉及饮食、起居、求医等各个环节
3. **持久稳定性**——文化价值观念和传统习俗根深蒂固，难以短时间改变
4. **双重性**——文化对健康既可能有积极促进作用，也可能有消极损害作用
5. **群体差异性**——不同文化背景人群的健康状况和健康行为存在显著差异

6.3 教育对健康的影响

！重点掌握：教育影响健康的机制：

1. **提高健康素养**——教育使人们获取和处理健康信息的能力增强，能够理解健康知识和遵从医嘱
2. **促进健康行为**——受教育程度高的人更可能采取积极健康的行为（合理饮食、适量运动、戒烟限酒等）
3. **增强应对能力**——教育提高人们应对生活压力和健康问题的能力
4. **改善职业和经济地位**——教育 → 更好的工作 → 更高的收入 → 更好的生活条件和医疗保障
5. **减少风险行为**——教育程度增高，吸烟、吸毒、酗酒等危险行为的发生率下降
6. **增强社会参与**——受教育程度高的人更多地参与社会活动，拥有更广泛的社会网络和支持
7. 母亲受教育水平对儿童健康的**独立保护效应**尤为显著

6.4 科技进步对行为与健康的影响

1. **积极影响：**医学技术进步（诊断、治疗、预防手段革新）、健康信息技术（电子健康档案、远程医疗、健康APP）、公共卫生监测和应急能力提升
2. **消极影响：**屏幕久坐行为增加（“电子久坐”）、互联网成瘾、睡眠紊乱（蓝光暴露）、信息误导（伪健康信息传播）、隐私泄露和基因歧视风险

6.5 风俗习惯对健康的影响

1. **有益健康的风俗：**中国传统饮食文化（均衡搭配、食疗养生）、饮茶习惯（抗氧化）、传统体育运动（太极拳、八段锦等）
2. **有害健康的风俗：**某些地区的嚼槟榔习惯（口腔癌风险）、高盐腌制食品消费（高血压、胃癌风险）、女性割礼（FGC）等陈规陋习
3. **需科学引导的风俗：**坐月子、特殊饮食禁忌等需结合现代医学知识加以科学化引导

6.6 宗教与道德对健康的影响

6.6.1 宗教

1. **积极方面**：提供精神慰藉和心理支持 → 减轻焦虑和抑郁；宗教倡导健康生活方式（禁止酗酒、暴饮等）→ 减少危险行为；宗教团体提供社会网络和支持；宗教教义中的积极心理暗示
2. **消极方面**：某些宗教习俗可能延误医疗救治（拒绝输血、拒绝接种疫苗等）；宗教狂热可能导致社会冲突和暴力；特定宗教规定可能影响营养和身体健康

6.6.2 道德

道德规范通过调节人们的社会行为间接影响健康：促进利他行为和互助 → 增强社区凝聚力和社会支持；约束危险行为（如对吸毒、酒驾的道德谴责）；医德伦理直接关系到医疗质量和患者健康。

6.7 非主流文化对健康的影响

[概念] 概念释义：非主流文化（亚文化与反文化）：与主流文化价值观念和行为规范相区别甚至相对立的文化形态和生活方式。

1. **亚文化群体**可能有特殊的健康风险：某些青年亚文化中药物滥用、危险性行为等风险较高
2. **反文化**可能与主流卫生倡导相抵触（如“反疫苗运动”）
3. 需关注文化适应（Acculturation）对移民群体健康的影响——文化冲突和文化适应压力可能导致心理问题

6.8 复习题

一、选择题

1. 文化影响健康的特点不包括：
(A) 潜移默化性
(B) 短暂易变性
(C) 广泛渗透性
(D) 双重性
2. 以下哪项不是教育影响健康的机制？
(A) 提高健康素养
(B) 改变遗传特征
(C) 促进健康行为
(D) 改善职业和经济地位
3. 受教育程度对以下哪一人群的健康影响最为显著？
(A) 成年男性
(B) 母亲（对儿童健康）
(C) 老年人
(D) 青少年

二、名词解释

1. 文化（Culture）
2. 文化适应（Acculturation）
3. 亚文化（Subculture）

三、简答题

1. 试述文化对人群健康影响的作用模式。
2. 简述文化影响健康的特点。
3. 简述教育影响健康的机制。
4. 举例说明风俗习惯对健康的影响（正反两方面）。

参考答案要点

一、选择题

1. (B)；2. (B)；3. (B)

二、名词解释

1. **文化**：广义指人类创造的物质和精神财富总和；狭义（社会医学关注）指社会意识形态及与之相适应的制度和组织机构，包括思想观念、价值体系、道德规范等精神文化要素。
2. **文化适应**：不同文化群体在持续接触过程中发生的一方或双方原有文化模式变化的现象，移民群体的文化适应对其健康有重要影响。
3. **亚文化**：社会某一群体特有的、区别于主流文化的文化模式和行为方式。

三、简答题

1. **四大模式**：文化决定健康观念模式（影响疾病认知和求医行为）；文化塑造健康行为模式（饮食、饮酒等日常行为）；文化影响卫生服务利用模式（现代 vs 传统医疗选择偏好）；文化调节心理应激反应模式（应激评价和应对策略选择）。
2. **五大特点**：潜移默化性、广泛渗透性、持久稳定性、双重性（促进和损害）、群体差异性。
3. **六方面机制**：提高健康素养、促进健康行为、增强应对能力、改善职业经济地位、减少风险行为、增强社会参与。母亲教育水平对儿童健康的独立保护效应最显著。
4. **正面**：传统饮食文化（均衡搭配）、饮茶习惯、太极拳；**负面**：嚼槟榔（口腔癌）、高盐腌制食品（高血压/胃癌）、女性割礼。

本章导览：掌握健康相关行为的概念及基本特征；掌握压力基本理论和健康行为的观点与理论（教学难点）；熟悉吸烟的危害及控烟政策措施；理解人格、认知等心理因素与健康的关系。

7.1 心理因素与健康

7.1.1 人格与健康

[概念] 概念释义：人格（Personality）：个体在遗传基础上，通过与后天环境的交互作用而形成的相对稳定、独特的心理行为模式的总和。

！重点掌握：人格与健康的关系——三种典型人格类型：

表 7-1 人格类型与健康的关系

类型	特征	健康风险
A 型人格	竞争性强、时间紧迫感、敌意和攻击性	冠心病的独立危险因素，风险为 B 型的 2 倍
B 型人格	悠闲自得、从容不迫、不易紧张	健康保护因素
C 型人格	过度克制、压抑情绪、顺从忍让	可能与癌症发生和进展有关

7.1.2 认知与健康

[概念] 概念释义：认知（Cognition）是人们对客观事物进行信息加工的认识过程，包括感觉、知觉、记忆、思维、想象和语言等。认知方式影响人们对健康信息的获取、理解和运用，以及疾病应对策略的选择。

7.1.3 心理压力与健康（教学难点 *）

！重点掌握：（教学难点 *）心理压力（Psychological Stress）的基本理论：

1. Selye 的应激理论（General Adaptation Syndrome, GAS）：

加拿大生理学家 Hans Selye 提出，应激是机体对各种刺激的非特异性反应，分为三个阶段：

1. 警觉反应阶段（Alarm Reaction）：机体识别应激源，启动“战斗或逃跑”（Fight or Flight）反应，交感神经系统和下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA 轴）激活
2. 抵抗阶段（Resistance）：机体适应持续存在的应激源，维持较高的生理激活水平，若适应成功则恢复
3. 衰竭阶段（Exhaustion）：如果应激持续存在且机体资源耗尽，适应能力下降，导致疾病或死亡

2. Lazarus 的认知评价理论：

压力不是客观刺激本身，而是个体对刺激的主观认知评价结果。三个阶段：

1. 初级评价（Primary Appraisal）：评价刺激是否构成威胁
2. 次级评价（Secondary Appraisal）：评价自己的应对资源和能力
3. 重新评价（Reappraisal）：根据新信息和新经验对刺激和应对能力重新评估

3. 持久过大压力的不良后果：

1. 心理障碍——焦虑症、抑郁症、创伤后应激障碍（PTSD）、职业倦怠（Burnout）
2. 心身疾病——冠心病、高血压、消化性溃疡、哮喘、免疫功能下降
3. 行为问题——物质滥用（酒精、烟草、成瘾药物）、饮食紊乱、社交退缩

4. 认知功能下降——注意力、记忆力、决策能力受损

7.2 健康相关行为

7.2.1 行为与健康相关行为

[概念] 概念释义：行为（Behavior）：个体在内外环境刺激作用下产生的可观察的反应和活动。

健康相关行为（Health-related Behavior）：个体或群体与健康 and 疾病有关的行为。分为两类：

- 促进健康行为（Health-promoted Behavior）：有利于健康的行为，如合理饮食、定期锻炼、规律作息、遵医行为等
- 危害健康行为（Health-risky Behavior）：不利于健康或导致疾病的行为，如吸烟、酗酒、吸毒、不合理饮食、缺乏运动等

7.2.2 健康相关行为的基本特征

1. 习得性：健康行为大多是通过学习和经验积累获得的，非先天固有
2. 稳定性与可变性：行为一旦形成具有一定稳定性，但可通过干预改变
3. 可干预性：行为是可改变的，通过健康教育、政策引导等手段进行干预
4. 社会性：行为受社会文化、经济、制度等社会因素影响
5. 累积性：行为的健康效应是长期累积的结果

7.2.3 健康行为的观点与理论（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）健康行为改变的主要理论：

1. 知信行模式（Knowledge-Attitude-Behavior Model, KAB/KAP）：

- 知识（Knowledge）→ 信念/态度（Attitude）→ 行为（Behavior）
- 认为健康知识是形成正确健康信念和态度的基础，健康信念和态度是行为改变的动力
- 局限性：知信行过程不是简单的线性关系，存在“知行不一”现象

2. 健康信念模型（Health Belief Model, HBM）：

由 Rosenstock 等提出，认为人们采取健康行为取决于以下五个因素：

1. 感知到易感性（Perceived Susceptibility）：认为自己可能患某种疾病
2. 感知到严重性（Perceived Severity）：认为疾病会带来严重后果
3. 感知到益处（Perceived Benefits）：认为采取健康行为有好处
4. 感知到障碍（Perceived Barriers）：认识到采取健康行为的障碍和代价
5. 行动线索（Cues to Action）：激发行为改变的内外提示

3. 阶段变化理论（Transtheoretical Model, TTM）：

由 Prochaska 和 DiClemente 提出，行为改变经历五个阶段：

1. 无意图期（Precontemplation）——未考虑改变
2. 意图期（Contemplation）——开始考虑改变
3. 准备期（Preparation）——准备采取行动
4. 行动期（Action）——已开始改变行为
5. 维持期（Maintenance）——持续保持新行为

4. 计划行为理论（Theory of Planned Behavior, TPB）：

行为意向受三个因素影响：行为态度；主观规范；知觉行为控制。

7.3 行为心理问题的干预

1. 健康教育与健康促进：提高健康素养，传播健康知识，塑造积极态度和行为
2. 认知行为治疗（CBT）：改变不良认知模式和行为习惯
3. 行为矫正（Behavior Modification）：运用正负强化、替代学习等手段
4. 环境干预：改变社会环境以支持健康行为（限烟区、健康食堂等）
5. 政策法规干预：立法限制危害健康行为（公共场所禁烟、酒驾处罚等）
6. 社区干预：以社区为基础的综合性行为干预项目

7.4 吸烟与控烟

7.4.1 吸烟的健康危害

！重点掌握：吸烟是最重要的可预防性致死原因。

- 吸烟与肺癌、COPD、冠心病、脑卒中等 25 种以上疾病密切相关
- 中国是全球最大的烟草消费国和生产国，吸烟人数约 3.5 亿
- **二手烟（被动吸烟）**同样严重危害健康，无“安全”暴露水平
- **三手烟（环境烟草烟雾残留）**也存在潜在健康危害
- 每年全球约 800 万人死于烟草相关疾病（其中约 100 万死于被动吸烟）

7.4.2 控烟的政策措施

1. **WHO《烟草控制框架公约》（FCTC）**——首个国际公共卫生条约（2003 年通过）
2. **MPOWER 六大控烟策略**（WHO，2008 年）：
 - **Monitor**——监测烟草使用和预防政策
 - **Protect**——保护人们免受烟草烟雾危害（无烟环境立法）
 - **Offer**——提供戒烟帮助
 - **Warn**——警示烟草危害（图形健康警示标签）
 - **Enforce**——禁止烟草广告、促销和赞助
 - **Raise**——提高烟草税和价格（最有效的单项措施）
3. **中国控烟措施：**《烟草控制法》推进、公共场所禁烟令、烟草税上调、烟盒警示标签

7.4.3 控烟倡导运动

[概念] 概念释义：倡导（Advocacy）：为动员政治和社会力量，推动政策改变和资源分配而采取的有组织的社会行动。控烟倡导通过四个方面——收集证据、建立联盟、媒体宣传、政策对话——推动控烟立法和政策实施。

7.5 复习题

一、选择题

1. Selye 将应激分为三个阶段，正确的顺序是：
 - (A) 抵抗 → 警觉 → 衰竭
 - (B) 警觉 → 抵抗 → 衰竭
 - (C) 衰竭 → 抵抗 → 警觉
 - (D) 警觉 → 衰竭 → 抵抗
2. 以下哪种人格类型被认为是冠心病的独立危险因素？
 - (A) A 型人格
 - (B) B 型人格
 - (C) C 型人格
 - (D) D 型人格
3. 计划行为理论（TPB）中行为意向不受以下哪个因素影响？
 - (A) 行为态度
 - (B) 主观规范
 - (C) 知觉行为控制
 - (D) 遗传因素
4. MPOWER 策略中，WHO 认为最有效的单项控烟措施是：
 - (A) 无烟环境立法
 - (B) 提供戒烟帮助
 - (C) 禁止烟草广告
 - (D) 提高烟草税和价格
5. 健康信念模型（HBM）不包括以下哪个要素？

- (A) 感知到易感性
- (B) 感知到严重性
- (C) 人格特质
- (D) 行动线索

二、名词解释

1. 健康相关行为 (Health-related Behavior)
2. 知信行模式 (KAB/KAP Model)
3. 倡导 (Advocacy)
4. 一般适应综合征 (GAS)

三、简答题

1. 试述 Selye 的应激理论 (GAS) 的三个阶段。
2. 简述健康信念模型 (HBM) 的五个核心要素。
3. 简述健康相关行为的基本特征。
4. 简述 WHO 的 MPOWER 六大控烟策略。
5. 简述行为心理问题的主要干预方法。

参考答案要点

一、选择题

1. (B); 2. (A); 3. (D); 4. (D); 5. (C)

二、名词解释

1. **健康相关行为**：个体或群体与健康 and 疾病有关的行为，分为促进健康行为和危害健康行为两类。
2. **知信行模式**：健康行为改变的理论模式，认为知识是态度/信念的基础，态度/信念是行为改变的动力，路径为知识 → 信念 → 行为。
3. **倡导**：为动员政治和社会力量推动政策改变和资源分配而采取的有组织社会行动。
4. **GAS**：Selye 提出的应激反应三阶段模型——警觉反应、抵抗和衰竭阶段。

三、简答题

1. 三阶段：警觉反应——机体识别应激源，交感神经和 HPA 轴激活，“战斗或逃跑”；抵抗——适应持续应激源，维持高生理激活水平；衰竭——资源耗尽，适应能力下降，导致疾病或死亡。
2. 五要素：感知到易感性、感知到严重性、感知到益处、感知到障碍、行动线索。人们采取健康行为的可能性取决于对疾病的威胁感知和改变行为的利弊权衡。
3. 五大特征：习得性、稳定性与可变性、可干预性、社会性、累积性。
4. Monitor (监测)、Protect (无烟环境保护)、Offer (提供戒烟帮助)、Warn (警示危害)、Enforce (禁止烟草广告促销赞助)、Raise (提高烟草税价)。烟草税是最有效的单项措施。
5. 主要方法：健康教育与健康促进、认知行为治疗 (CBT)、行为矫正 (正负强化)、环境干预 (限烟区、健康食堂)、政策法规干预 (禁烟令等)、社区综合性干预。

本章导览：掌握定性研究和定量研究的概念、特点与实际应用；掌握效度和信度的概念、类型及关系（**教学难点**）；熟悉社会医学研究的步骤和课题评价三原则、问卷设计的原则和方法；了解非概率抽样方法和常见问题。

8.1 社会医学研究概述

8.1.1 社会医学的相关研究方法

社会医学研究综合运用多种研究方法：

1. **调查研究法**——最常用的方法，包括问卷法、访谈法、观察法等
2. **文献研究法**——系统查阅和分析已有文献资料
3. **实验研究法**——社会干预实验、健康教育效果评价等
4. **比较研究法**——不同人群、地区、时期之间的比较
5. **综合评价法**——健康危险评价、生命质量评价、卫生服务综合评价等

8.1.2 社会医学研究的步骤

社会医学研究的五个步骤

1. **选题与确定研究问题**——根据实际需求、资料可及性和研究条件提出明确的研究问题
2. **制定研究设计/方案**——包括研究目的、对象、方法、资料收集和分析方案、时间进度、经费预算等
3. **收集资料**——通过问卷、访谈、观察、文献等方式收集原始资料和二手资料
4. **整理和分析资料**——定性资料和定量资料的整理、编码、统计分析或内容分析
5. **撰写研究报告**——研究报告的规范格式包括前言（问题背景）、研究设计和实施、结果、讨论与建议

8.1.3 课题评价三原则

！重点掌握：课题评价的三个基本原则：

1. **需要性原则**——研究问题应满足社会卫生实践的需要或理论发展的需要，解决实际问题
2. **创新性原则**——研究问题应有一定的新颖性，在前人研究基础上有所突破或创新
3. **科学性原则**——研究问题应具备科学依据和理论支撑，方法科学、设计合理

此外，还应考虑**可行性原则**——研究目标在现有条件下（人力、物力、财力、时间等）是否可以实现。

8.1.4 非概率抽样

[概念] 概念释义：非概率抽样（Non-probability Sampling）：不按概率均等原则抽取样本，而是根据研究者的主观判断或便利条件选择研究对象。在社会医学的定性研究中广泛应用。

四种主要类型：

表 8.1: 非概率抽样方法比较

方法	定义	特点与适用
方便抽样 (Convenience/Accidental Sampling)	选择最方便接触到的研究对象	简单易行但代表性差; 适用于初步探索和预调查
立意抽样 (Purposive/Judgmental Sampling)	根据研究者判断和目的选择有代表性的对象	灵活但主观性强; 适用于了解典型个案
滚雪球抽样 (Snowball Sampling)	从已知研究对象开始, 由他们推荐符合条件的新研究对象	适用于难以找到的”隐藏人群”(如静脉吸毒者、性工作者等)
定额抽样 (Quota Sampling)	按某些特征将总体分层后非随机抽取各层样本	在各层按比例抽取, 但各层内非随机; 可用于快速调查

8.2 定性研究

[概念] 概念释义：定性研究 (Qualitative Research)：通过与研究对象的深入互动来理解人们的行为、观点、经验和感受，获取深层次信息的研究方法。研究结果以文字描述形式呈现。

特点：

1. 注重对事物的深层理解和”意义”的挖掘
2. 研究设计灵活，可在研究过程中调整
3. 样本量较小，采用非概率抽样
4. 资料收集以开放式交流为主
5. 结果难以推广到大范围人群，但具有深刻性

8.2.1 常用定性研究方法

！重点掌握：四种主要定性研究方法：

1. 深入访谈法 (In-depth Interview)：
 - 访谈者与被访者一对一深入交谈
 - 按事先准备的访谈提纲进行
 - 开放式问题，鼓励被访者自由表达
 - 时间：通常 30 分钟-2 小时
 - 适用于：敏感问题、复杂问题的深入探讨
2. 焦点组讨论 (Focus Group Discussion, FGD)：
 - 8-12 人为一组，在主持人引导下围绕特定主题进行讨论
 - 利用群体互动激发观点和见解
 - 时间：通常 1-2 小时
 - 优势：高效、经济，群体互动产生丰富信息
 - 劣势：个别个体可能主导讨论，敏感问题不适合
 - 案例：一项研究进行了 18 场共 10 小时的焦点组讨论
3. 提名小组讨论 (Nominal Group Discussion)：
 - 结构化较强的定性方法
 - 成员先独立书面回答问题，再依次分享、讨论、排序
 - 减少了群体压力和个别主导问题
4. 观察法 (Observation)：
 - 参与式观察——研究者融入被研究群体
 - 非参与式观察——研究者保持客观旁观
 - 适用于研究实际行为（而非口头报告的行为）

8.2.2 定性研究资料的处理与分析

1. 将录音/录像资料转录为文字
2. 反复阅读资料，熟悉内容

- 3. 编码——对资料进行主题分类编码
- 4. 提取主题——归纳核心主题和模式
- 5. 解释和分析——结合理论框架进行深度解读
- 6. 撰写报告——用引语（受访者原话）支撑分析结果

8.3 定量研究

[概念] 概念释义：定量研究（Quantitative Research）：通过收集和分析数量化资料来检验假设、描述事物特征和因果关系的研究方法。研究结果以数值形式呈现，可进行统计分析。

特点：

- 1. 研究设计结构化、标准化程度高
- 2. 样本量大，采用概率抽样
- 3. 资料以数字形式收集和分析
- 4. 结果可推广到目标总体
- 5. 强调客观性和可重复性

8.3.1 访谈法与自填法

！重点掌握：访谈法（Interview Method）与自填法（Self-administered Method）的比较：

表 8-2 访谈法与自填法的优缺点比较

比较维度	访谈法	自填法
优点	(1) 应答率高；(2) 可获得较高质量资料；(3) 可观察受访者表情反应；(4) 可辅助解释和澄清问题	(1) 省时省力，成本低；(2) 可匿名填写，适用于敏感问题；(3) 无访谈者偏倚；(4) 可大规模同时进行
缺点	(1) 费时人力成本高；(2) 访谈者偏倚；(3) 匿名性差；(4) 受访者可接触的样本量受限	(1) 应答率低；(2) 不能解释和澄清问题；(3) 无法确定填写者；(4) 问题顺序可能被跳过

8.4 问卷设计

8.4.1 问卷的概念、类型和结构

[概念] 概念释义：问卷（Questionnaire）：由一系列与研究目标相关的问题组成的调查工具，用于系统地收集研究对象的特征、行为、态度、知识等信息。

问卷类型：

- 按填写方式：自填式问卷、访谈式问卷
- 按发放方式：现场问卷、邮寄问卷、网络问卷、电话问卷

问卷结构：

- 1. 封面信/卷首语——说明调查目的、意义、保密承诺、填写方法、致谢
- 2. 指导语——具体说明如何填写和回答问题
- 3. 问题与答案——问卷的主体部分
- 4. 编码——便于计算机录入和分析

8.4.2 问卷设计的原则和步骤

！重点掌握：问卷设计六原则：

- 1. 目的性原则——所有问题应紧密围绕研究目的
- 2. 可接受性原则——问题易于理解，应答者愿意回答
- 3. 逻辑性原则——问题编排有逻辑顺序，由浅入深
- 4. 简明性原则——问题简洁明了，避免冗长复杂
- 5. 可接受性原则——考虑文化和道德接受度

6. 科学性原则——问题设计科学，能有效测量研究变量

问卷设计七步骤：确定所需信息 → 选择问卷类型 → 设计问题 → 确定问题顺序 → 预调查 → 修改完善 → 定稿印刷

8.4.3 封闭式问题与开放式问题

表 8.2: 封闭式与开放式问题的比较		
比较	封闭式问题	开放式问题
定义	提供固定选项，应答者从中选择	不提供选项，应答者自由回答
优点	易于编码和统计分析；回答率高；节省时间	可获取丰富详细的信息；不受选项限制；可能发现新问题
缺点	选项可能不全；不能深入了解；限制应答者的表达	编码困难；应答率低；分析工作量大；受表达能力影响

8.4.4 问卷设计常见错误及注意事项

[提示] 要点提示：问卷设计常见的错误：

1. 双重问题（Double-barreled Question）——一个问题包含两个以上询问内容

2. 诱导性问题（Leading Question）——问题措辞暗示了期望的答案

3. 专业术语过多——受访者难以理解

4. 问题含糊不清——不同应答者理解不一致

5. 选项不互斥或不穷尽——答案选项设计缺陷

6. 回忆性偏倚——要求应答者回忆太久远的事情

7. 敏感问题放置不当——引起应答者防御心理

问题排列顺序原则：

• 从简单到复杂，从一般到具体

• 从非敏感到敏感问题（敏感问题放在后面）

• 同类问题集中排列

• 漏斗式编排——先宽后窄

8.5 效度与信度

8.5.1 效度的概念与类型（教学难点*）

[概念] 概念释义：效度（Validity）：（教学难点*）指测量工具或手段能够准确测出所需测量的事物的程度，即”测的是否正确”（准确性）。

效度的四种类型：

1. 表面效度（Face Validity）：从表面上主观判断测量工具是否看起来测量了所要测的内容。是最基本层次的效度，非正式评估

2. 内容效度（Content Validity）：测量工具的内容是否全面、均衡地涵盖了所要测量的概念领域。通过专家评定来判断

3. 效标效度（Criterion Validity）：用测量工具的测量结果与某个效标（金标准）进行比较的一致性程度。分为：

• 同时效度（Concurrent Validity）——与同时测量的效标比较

• 预测效度（Predictive Validity）——与将来测量的效标比较

4. 结构效度（Construct Validity）：测量工具实际测量到的理论结构和特质与假设的理论结构相符合的程度。是最深层次的效度

8.5.2 信度的概念与类型（教学难点*）

[概念] 概念释义：信度（Reliability）：（教学难点*）指采用同一方法对同一对象重复测量时所得结果的一致性程度，即“测量结果的一致性或稳定性”（可靠性）。

信度的四种类型：

1. 重测信度（Test-Retest Reliability）：同一量表对相同对象在不同时间重复测量，两次结果的相关性。间隔时间不宜过短（记忆效应）或过长（真实变化）
2. 复本信度（Parallel-Forms Reliability）：两个等价的测量工具版本对同批对象测量的结果一致性
3. 折半信度（Split-Half Reliability）：将量表问题分为两半（如奇数题和偶数题），计算两部分得分的一致性
4. 内部一致性信度（Internal Consistency Reliability）：量表各条目测量同一概念的程度，常用Cronbach's α 系数衡量， $\alpha \geq 0.70$ 为可接受， $\alpha \geq 0.80$ 为良好

8.5.3 信度与效度的关系（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）信度与效度的关系：

核心关系：信度是效度的必要条件，但不是充分条件。

1. 信度高，效度不一定高——测量结果可能稳定但测的不是想要测量的内容（如用体重秤来“测量”身高——每次都得到一致的结果，但数值是错的）
2. 效度高，信度一定高——如果测量工具确实测量了想测的内容，那么结果必定是可重复和稳定的
3. 信度低，效度一定低——测量结果本身不稳定、不可靠，就不可能有准确的测量
4. 效度低，信度不一定低——可能稳定地测到了别的内容

形象的比喻：打靶

- 高效度高信度：弹孔集中（信度高）在靶心（效度高）
- 高信度低效度：弹孔集中（信度高）但偏离靶心（效度低）
- 无信度无效度：弹孔分散且偏离靶心——测量无价值

[提示] 要点提示：如何在研究中保证信度和效度：

- 严格的研究设计和标准化操作流程
- 预调查和预测试，检验测量工具的信度和效度
- 访谈员培训和质量控制
- 使用广泛验证过的标准化量表
- 三角验证（Triangulation）——多种方法和来源的数据相互验证

8.6 复习题

一、选择题

1. 以下哪种抽样方法属于非概率抽样？
(A) 单纯随机抽样
(B) 系统抽样
(C) 分层抽样
(D) 滚雪球抽样
2. 用于测量量表各条目测量同一概念程度的信度指标是：
(A) 重测信度
(B) 复本信度
(C) 内部一致性信度
(D) 折半信度
3. 关于信度与效度的关系，以下哪项是正确的？
(A) 信度高，效度一定高
(B) 效度低，信度一定低
(C) 效度高，信度一定高
(D) 信度与效度无关
4. 焦点组讨论的理想参与人数一般为：

- (A) 2-4 人
- (B) 8-12 人
- (C) 20-30 人
- (D) 50 人以上

5. 问卷设计中的“双重问题”是指：

- (A) 一个问题有两个选项
- (B) 一个问题包含两个以上的询问内容
- (C) 两个问题完全一样
- (D) 问题被重复问两次

二、名词解释

1. 定性研究 (Qualitative Research)
2. 效度 (Validity)
3. 信度 (Reliability)
4. 非概率抽样

三、简答题

1. 试比较定性研究与定量研究的主要区别。
2. 简述效度的四种类型及含义。
3. 简述信度的四种类型及含义。
4. 试述信度与效度的关系。
5. 简述问卷设计的基本原则和常见错误。

参考答案要点

一、选择题

1. (D); 2. (C); 3. (C); 4. (B); 5. (B)

二、名词解释

1. **定性研究**：通过与研究对象深入互动了解其行为、观点和体验的研究方法，结果以文字形式呈现，注重深层理解。
2. **效度**：测量工具准确测出所需测量事物的程度，即“测的是否正确”。
3. **信度**：同一方法对同一对象重复测量结果的一致性程度，即“测量结果的稳定性”。
4. **非概率抽样**：不按概率均等原则抽取样本，根据主观判断或便利条件选择对象，包括方便抽样、立意抽样、滚雪球抽样和定额抽样。

三、简答题

1. **定性**：深入理解意义、设计灵活、样本小、非概率抽样、开放式交流、文字描述。**定量**：检验假设、设计结构化、样本大、概率抽样、标准量表、数值分析、可推广。
2. **四种类型**：表面效度（主观判断“看起来是否测对了”）；内容效度（是否全面涵盖测量领域）；效标效度（与金标准比较，分同时效度和预测效度）；结构效度（与理论结构的吻合程度，最深层次）。
3. **四种类型**：重测信度（不同时间重复测量的稳定性）；复本信度（两个等价版本的一致性）；折半信度（量表分半的一致性）；内部一致性信度（Cronbach's α 系数，各条目内在一致性）。
4. **核心**：信度是效度的必要条件而非充分条件。信度高，效度不一定高；效度高，信度一定高；信度低，效度一定低；效度低，信度不一定低。
5. **六原则**：目的性、可接受性、逻辑性、简明性、可接受性、科学性。常见错误：双重问题、诱导性问题、专业术语过多、问题含糊、选项不互斥/穷尽、回忆偏倚、敏感问题放置不当。

本章导览：掌握卫生服务研究的概念（**教学难点**）；掌握卫生服务需要、需求与利用的概念及相互关系（**教学难点**）；掌握卫生服务的综合评价（**教学难点**）；熟悉卫生资源、卫生费用的概念及评价指标；了解卫生服务研究的内容、方法和我国进展。

9.1 卫生服务研究概述

[概念] 概念释义：卫生服务研究（Health Services Research）：**（教学难点 *）**是从社会学、管理学、经济学等多学科视角，系统研究**卫生服务的组织、提供、利用、质量和效果**的科学。其核心是研究如何合理组织和有效利用卫生资源，最大程度地满足人群的卫生服务需要，提高卫生服务的质量和效率。

9.1.1 卫生服务研究的意义与目的

1. **为卫生政策制定提供科学依据**——了解人群的卫生服务需要和需求、利用模式
2. **优化卫生资源配置**——发现资源配置不合理之处，提出调整方案
3. **提高卫生服务质量和效率**——评价卫生服务的质量和效果
4. **促进卫生服务公平性**——识别服务可及性和利用的差异，减少健康不公平
5. **评价卫生改革的效果**——对卫生政策、项目和改革的实施效果进行科学评估

9.1.2 我国卫生服务研究的进展

- 1981 年：中美合作在上海县开展卫生服务研究，开创了我国系统化卫生服务研究先河
- 1985 年后：逐步在全国推广卫生服务研究方法
- 1993 年起：每 5 年开展一次**国家卫生服务调查**（National Health Services Survey），已进行 6 次（1993、1998、2003、2008、2013、2018 年）
- ”国家卫生服务调查”已成为我国卫生政策制定的重要数据来源

9.1.3 卫生服务研究的内容

卫生服务研究的六大内容

1. **卫生服务需要与需求**——人群健康状况及主观医疗服务需要
2. **卫生服务利用**——门诊、住院、预防保健等服务的实际使用
3. **卫生资源**——人力、物力、财力、信息等资源的配置和分布
4. **卫生服务评价**——服务效果、效率、质量、公平性和可及性评价
5. **卫生系统绩效**——卫生系统的整体效率和目标达成情况
6. **卫生政策与改革**——政策制定、实施和效果评估

9.1.4 卫生服务研究的方法

1. 常规资料分析——利用常规统计报表和行政记录数据
2. 家庭卫生服务调查——入户问卷调查获取人群层面的数据
3. 机构调查——对医疗卫生机构的资源、服务量、费用等进行调查
4. 定性研究——深入访谈和焦点组讨论了解利益相关者的经验和观点
5. 综合评价方法——运用统计学和管理学方法进行综合评价

9.2 卫生服务需要、需求与利用

9.2.1 基本概念（教学难点 *）

！重点掌握：（教学难点 *）三个核心概念的区别与联系：

[概念] 概念释义：卫生服务需要（Health Need）：从健康（卫生）角度出发，由医学专业人员根据健康标准判断的**实际健康需要**。包括：个人察觉到的需要（主观需要）和卫生专业人员判定的需要（客观需要）。

卫生服务需求（Health Demand）：从经济学角度，在**一定的价格水平下，消费者愿意并且有能力购买**的卫生服务量。需求 = 需要 + 购买意愿 + 购买能力。

卫生服务利用（Health Service Utilization）：人群**实际使用**卫生服务的情况，包括门诊服务利用、住院服务利用和预防保健服务利用等。

需要、需求、利用三者的关系：

- 需要 需求：**有需要的人不一定有需求（如因经济困难、交通不便未就医）；有需求的人不一定有需要（如不必要的体检和药品需求——”诱导需求”）
- 需求 利用：**有需求的人可能因各种障碍（等待时间过长、交通不便等）未能实际利用服务
- 需要 → 需求 → 利用**是医疗服务转化的理想路径，但转化过程中存在多种障碍
- 未满足的需要（Unmet Need）：**有卫生服务需要但没有转化为需求和利用，是需要重点关注的问题

9.2.2 影响卫生服务需要与利用的因素

- 人口学特征：**年龄（老年人和儿童需要更多服务）、性别（女性利用率较高）
- 社会经济因素：**收入水平（低收入人群未满足需要更多）、教育程度、职业、医疗保险覆盖
- 健康状况：**患病率和疾病严重程度是决定需要的最基本因素
- 卫生服务供给：**服务的地理可及性、服务质量、价格和等待时间
- 文化和信念：**对健康和疾病的文化认知、就医观念和习惯
- 政策与制度：**医疗保险制度、转诊制度、支付方式等政策因素

9.2.3 常用指标

表 9.1: 卫生服务需要与利用常用指标	
指标类型	具体指标
卫生服务需要指标	两周患病率 = 两周内患病人数/调查人数 × 100%；慢性病患病率；健康自评状况；疾病频率指标
门诊服务利用指标	两周就诊率 = 两周内就诊人数/调查人数 × 100%；年人均就诊次数；未就诊率及未就诊原因分析
住院服务利用指标	住院率 = 一年内住院人数/调查人数 × 100%；人均住院天数；应住院未住院率及原因
预防保健利用指标	计划免疫覆盖率、产前检查率、住院分娩率、健康体检率等

9.3 卫生资源

[概念] 概念释义：卫生资源（Health Resources）：社会投入到卫生服务中的人力、物力、财力、技术和信息等资源的统称。

9.3.1 卫生人力资源

[概念] 概念释义：卫生人力资源（Health Human Resources）：接受过卫生专业教育和培训，从事卫生服务相关工作的人员的总称。是卫生资源中**最核心、最活跃的要素**。

研究内容：卫生人力的数量、质量、结构和分布（城乡、地区、机构层级之间）。

9.3.2 卫生费用

[概念] **概念释义：**卫生总费用（Total Health Expenditure, THE）：一个国家或地区在一定时期内（通常为一年）全社会用于卫生保健支出的货币总和。

- **来源：**政府卫生支出（各级政府财政卫生拨款）；社会卫生支出（社会医疗保险、商业健康保险、企业办医支出等）；个人现金卫生支出（居民个人直接支付的医药费用）
- **分类：**经常性卫生费用（人员经费、药品、材料等日常费用）和基本建设费用（房屋、设备等投资性费用）
- **评价指标：**卫生总费用占 GDP 的百分比；人均卫生总费用；政府卫生支出占财政支出的百分比；个人现金卫生支出占 THE 比重（目标为降至 30% 以下，降低”灾难性卫生支出”风险）

9.4 卫生服务的综合评价（教学难点 *）

！重点掌握：（教学难点 *）卫生服务的综合评价模式是将卫生服务需要、卫生资源投入和卫生服务利用三者结合起来进行综合分析的方法。

综合评价矩阵：根据**需要量（高/低）**与**资源投入（高/低）**与**服务利用（高/低）**三个维度的组合，将不同地区分为八种类型：

表 9-2 卫生服务综合评价矩阵

需要	资源	利用	综合评价
高	高	高	A 型——资源充足、利用良好、供需平衡
高	高	低	B 型——资源充足但利用不足，需提高利用效率
高	低	高	C 型——资源不足但利用高，需增加资源投入
高	低	低	D 型——资源不足利用差，需全面加强
低	高	高	E 型——可能存在资源过剩或诱导需求
低	高	低	F 型——资源过剩但利用不足，效率低下
低	低	高	G 型——资源低但利用相对好，效率尚可
低	低	低	H 型——需要、资源、利用均低，视情况调整

综合评价的意义：

1. 帮助发现不同地区卫生服务的主要问题和瓶颈
2. 为卫生资源配置和服务规划提供科学依据
3. 综合评价三个维度，避免单一指标的片面评价
4. 适用于地区间比较和不同时期的纵向比较

9.5 复习题

一、选择题

1. 以下哪个概念是指”消费者愿意并有能力购买的卫生服务量”？
(A) 卫生服务需要
(B) 卫生服务需求
(C) 卫生服务利用
(D) 卫生服务供给
2. 我国国家卫生服务调查首次开展于：
(A) 1981 年
(B) 1985 年
(C) 1993 年
(D) 1998 年
3. 卫生总费用（THE）的来源不包括：
(A) 政府卫生支出
(B) 社会卫生支出
(C) 国际援助

(D) 个人现金卫生支出

4. 综合评价矩阵中，资源充足但利用不足的类型是：

- (A) A 型
- (B) B 型
- (C) C 型
- (D) D 型

二、名词解释

1. 卫生服务需要 (Health Need)
2. 卫生服务需求 (Health Demand)
3. 卫生服务利用 (Health Service Utilization)
4. 卫生总费用 (THE)

三、简答题

1. 试述卫生服务需要、需求与利用三者之间的区别与联系。
2. 简述影响卫生服务需要与利用的主要因素。
3. 简述卫生服务的综合评价模式。
4. 简述我国国家卫生服务调查的发展历程。

参考答案要点

一、选择题

1. (B); 2. (C); 3. (C); 4. (B)

二、名词解释

1. **卫生服务需要**：从健康角度由专业人员判断的实际健康需要，包括主观需要和客观需要。
2. **卫生服务需求**：在一定的价格水平下，消费者愿意并有能力购买的卫生服务量。需求 = 需要 + 购买意愿 + 购买能力。
3. **卫生服务利用**：人群实际使用卫生服务的情况，包括门诊、住院和预防保健服务利用。
4. **卫生总费用 (THE)**：一个国家或地区在一定时期内全社会用于卫生保健支出的货币总和，来源包括政府、社会和个人三方面。

三、简答题

1. 三者关系：需要 需求 利用。需要是健康角度的客观判定；需求需要购买意愿和能力；利用是实际使用。存在的差距：有需要无需求（经济障碍）、有需求无利用（等待时间等障碍）、无需要有需求（诱导需求）。
2. 六大因素：人口学特征（年龄、性别）、社会经济因素（收入、教育、医保）、健康状况（患病率）、服务供给（可及性、质量、价格）、文化和信念、政策制度（医保、转诊、支付方式）。
3. 综合评价模式根据**需要量（高/低）**、**资源投入（高/低）**和**服务利用（高/低）**三个维度分为八种类型（A-H 型），综合分析供需平衡状况，为资源配置和服务规划提供依据。
4. 1981 年中美合作上海县研究开创先河；1993 年起每 5 年开展一次国家卫生服务调查，至今已 6 次；成为卫生政策制定的重要数据来源。

本章导览：掌握健康危险因素评价的概念、步骤（**教学难点**）；掌握危险分数的意义和来源、评价年龄和增长年龄的概念（**教学难点**）；熟悉健康危险因素的个人和群体评价方法；了解健康危险因素的概念、分类特点及大数据应用。

11.1 健康危险因素概述

[概念] 概念释义：健康危险因素（Health Risk Factors）：能使疾病或死亡发生的可能性增加的因素，或者能使健康不良后果发生概率增加的因素。

11.1.1 健康危险因素的分类

健康危险因素的四大分类

1. **环境因素**——自然环境（空气、水、土壤污染）；社会环境（经济、文化、教育、社会支持等）
2. **生物遗传因素**——遗传易感性、家族史、年龄、性别等
3. **行为生活方式因素**——吸烟、酗酒、不合理饮食、缺乏运动、药物滥用等
4. **医疗卫生服务因素**——卫生服务可及性、质量、医疗保障覆盖等

11.1.2 健康危险因素的特点

1. **潜伏期长**——危险因素暴露后往往经过很长时间才出现疾病后果
2. **联合作用**——多种危险因素同时存在的联合作用比单个因素大
3. **广泛存在**——危险因素在人群中广泛分布
4. **特异性弱**——一种危险因素可与多种疾病相关，一种疾病也可与多种因素相关
5. **可干预性**——许多危险因素可以通过行为和环境的改变加以控制和消除

11.1.3 健康危险因素的作用过程

1. 危险因素暴露 → 机体内部分子/细胞/生理发生变化 → 亚临床状态 → 临床疾病 → 死亡
2. 大部分危险因素通过影响机体中间表型（血压、血脂、血糖等）间接导致疾病
3. 危险因素之间存在相互作用，如吸烟 + 饮酒的协同致癌效应

11.2 健康危险因素评价

[概念] 概念释义：健康危险因素评价（Health Risk Appraisal/Assessment, HRA）：研究危险因素与慢性病发病及死亡之间数量依存关系及其规律性的一种技术方法。通过收集个体生活方式、健康检查、家族史等信息，定量评估个体在未来一定时期内发病或死亡的风险，以及通过改变不良行为而避免或延缓发病或死亡的可能性。

11.2.1 评价步骤（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）健康危险因素评价的四大步骤：

第一步：收集资料

1. **当地死亡资料**——按年龄、性别、死因别死亡率（通常取最近 3-5 年平均）
2. **个体危险因素资料**——通过问卷调查、体格检查和实验室检测获取
 - 行为生活方式：吸烟、饮酒、体力活动、饮食等
 - 体格检查：身高、体重、血压等
 - 实验室检查：血糖、血脂、肝功能等
 - 家族史：主要慢性病的家族史
3. **危险分数资料**——危险因素与死亡率之间定量关系的流行病学证据（来自大规模队列研究或 Meta 分析）

第二步：计算危险分数

- **危险分数的概念**（教学难点*）：危险因素处于某一水平时发生某病死亡的危险与人群平均死亡危险的比值
- 基准：全死因平均死亡危险 = 1.0
- 危险分数 > 1.0：该个体的死亡危险高于同龄同性别平均人群水平
- 危险分数 < 1.0：该个体的死亡危险低于平均人群水平
- **组合危险分数**：综合考虑多种危险因素后计算出的总危险分数

第三步：计算评价年龄与增长年龄

- **评价年龄（Appraisal Age）**：根据个体存在的危险因素，依据死亡率与年龄的函数关系推算出的该个体当前的“疾病死亡危险性相当于某一年龄的平均水平”。评价年龄 > 实际年龄表示危险因素水平高于平均水平
- **增长年龄（Achievable Age/可达到年龄）**：如果该个体采取医生建议的控制危险因素的措施后，可能达到的“相当于某一年龄的平均水平”。增长年龄 ≤ 评价年龄
- **危险降低量** = 评价年龄 - 增长年龄：反映通过行为改变可获得的健康收益

第四步：评价与建议

- 向个体或群体反馈评价结果
- 指出主要危险因素及可改变的方向
- 给出具体的健康促进和疾病预防建议

11.2.2 健康危险因素的个体评价方法

！重点掌握：根据评价年龄和增长年龄与**实际年龄**的关系，被评估者分为四种类型：

1. **健康型**：评价年龄 < 实际年龄。个体的危险因素水平低于人群平均水平，健康状况良好
2. **存在少量危险因素型**：评价年龄 ≈ 实际年龄，略高于或等于。有少量危险因素但影响不大
3. **存在危险因素但可改变型**：评价年龄 > 实际年龄，但增长年龄与评价年龄差距较大（危险降低量 > 1 岁）。有较多危险因素但多数可改变，通过干预可显著降低健康风险
4. **存在大量不可改变危险因素型**：评价年龄 > 实际年龄，且增长年龄与评价年龄差距较小（危险降低量 ≤ 1 岁）。危险因素中有大量不可改变因素（年龄、遗传等），可干预空间有限

11.2.3 健康危险因素的群体评价方法

1. **危险分数分布分析**：将群体按危险分数分组，分析不同危险水平人群的分布规律
2. **归因危险度分析**：计算某危险因素在人群中导致疾病的归因分值，评估其公共卫生学意义
3. **潜在寿命损失分析**：估计去除某危险因素后可能避免的死亡和寿命损失
4. **群体干预效果模拟**：模拟不同干预策略下人群健康的改善效果

11.3 大数据与健康危险因素评价

1. 大数据技术为 HRA 提供更精准的个体风险预测——整合电子健康档案、可穿戴设备数据、基因组学数据
2. 机器学习算法可识别传统方法难以捕捉的复杂危险因素交互作用
3. 实时监测和预测健康风险——可穿戴设备 + 手机 APP 的持续健康监测
4. 个性化健康管理——基于个人风险图谱的精准干预建议

11.4 复习题

一、选择题

- 健康危险因素评价中，基准危险分数为：
(A) 0.5
(B) 1.0
(C) 1.5
(D) 2.0
- 评价年龄大于实际年龄说明：
(A) 个体危险因素水平低于平均
(B) 个体危险因素水平高于平均
(C) 个体健康状况极好
(D) 无法判断
- 危险降低量等于：
(A) 实际年龄 - 评价年龄
(B) 评价年龄 - 增长年龄
(C) 增长年龄 - 实际年龄
(D) 增长年龄 - 评价年龄
- 健康危险因素评价中被评估者分为四种类型，其中“危险因素可改变但尚未改变”的是：
(A) 健康型
(B) 存在少量危险因素型
(C) 存在危险因素但可改变型
(D) 存在大量不可改变危险因素型

二、名词解释

- 健康危险因素评价 (HRA)
- 评价年龄 (Appraisal Age)
- 增长年龄 (Achievable Age)
- 危险分数

三、简答题

- 简述健康危险因素评价的四大步骤。
- 简述健康危险因素个体评价的四种类型。
- 简述危险分数、评价年龄和增长年龄三者之间的关系。
- 简述健康危险因素的特点。

参考答案要点

一、选择题

1. (B); 2. (B); 3. (B); 4. (C)

二、名词解释

- HRA**: 研究危险因素与慢性病发病及死亡之间数量依存关系的一种技术方法，定量评估个体未来发病或死亡风险及通过行为改变可避免的程度。
- 评价年龄**: 根据个体危险因素，依据死亡率与年龄的函数关系推算的“相当于某年龄平均水平”的年龄。
- 增长年龄**: 个体采取控制危险因素措施后可能达到的“相当于某年龄平均水平”的年龄。
- 危险分数**: 危险因素处于某水平时发生某病死亡的危险与人群平均死亡危险的比值，基准为 1.0。

三、简答题

- 四步：收集资料（当地死亡率资料、个体危险因素资料、危险分数资料）；计算危险分数（单个因素危险分数 → 组合危险分数）；计算评价年龄和增长年龄；评价与建议（反馈结果、指出主要可改变因素、给出干预建议）。

2. 四种类型：健康型（评价年龄 $<$ 实际年龄）；存在少量危险因素型（评价年龄 $\approx$ 实际年龄）；存在危险因素但可改变型（评价年龄 $>$ 实际年龄，危险降低量大）；存在大量不可改变因素型（评价年龄 $>$ 实际年龄，危险降低量小）。
3. 三者关系：危险分数决定了评价年龄（危险分数越高 $\rightarrow$ 评价年龄越大）；增长年龄是控制危险因素后可能达到的年龄（通常 $\leq$ 评价年龄）；危险降低量 = 评价年龄 - 增长年龄，反映可干预空间。
4. 五大特点：潜伏期长、联合作用、广泛存在、特异性弱、可干预性。

本章导览：掌握生命质量的评价方法（**教学难点**）；熟悉生命质量的概念与构成、评价内容；了解生命质量的测量工具及其应用领域。

12.1 生命质量的概念与构成

12.1.1 生命质量的概念

[概念] 概念释义：生命质量（Quality of Life, QOL）：由美国经济学家 Galbraith 于 20 世纪 50 年代提出。在社会医学领域，生命质量指不同文化和价值体系中的个体对与其目标、期望、标准以及所关心事情有关的生活状态的体验。

健康相关生命质量（Health-related Quality of Life, HRQOL）：在疾病、意外损伤及医疗干预的影响下，测定与个人生活事件相联系的主观健康状态和个体满意度。

！重点掌握：WHO 对生命质量的定义：

不同文化和价值体系中的个体对与他们的目标、期望、标准以及所关心事情有关的生活状态的体验。包含以下核心要素：

- 主观性——以个体自身体验为核心
- 多维度性——包含身体、心理、社会等多维度
- 文化依赖性——受文化背景和价值观念的影响

12.1.2 生命质量的构成

生命质量的构成维度

1. **生理状态**——身体功能（活动能力、自理能力）、感官功能（视力、听力）、疾病症状和体征、体力
2. **心理状态**——情绪状态（焦虑、抑郁等）、认知功能（记忆、注意力、思维）、自我评价（自尊、自我效能感、生活满意度）
3. **社会功能状态**——社会角色功能（工作、学习能力）、社会交往与人际关系、社会参与和社会支持
4. **角色功能（Role Function）**——能否完成日常社会角色要求。角色功能障碍表现为工作能力下降、家务能力下降等
5. **总体健康感受和满意度**——对自身健康和生活状况的总体主观评价

12.2 生命质量的评价内容与方法

12.2.1 评价内容

1. **生理功能评价：**活动受限（自理能力、躯体活动、体力活动等）、角色受限（工作、学习、家务等受限天数）
2. **心理功能评价：**情绪反应（焦虑、抑郁等心理困扰）、认知功能（注意力、记忆力、思维清晰度）
3. **社会功能评价：**社会交往的频率和质量、社会资源的利用
4. **总体健康评价：**健康自评（Self-rated Health）——个体对自己健康状况的总体主观评价；生活满意度

12.2.2 评价方法（教学难点 *）

！重点掌握：（教学难点 *）生命质量评价的主要方法：

1. 量表评定法（最常用）：

- 通过标准化问卷获取个体对各个维度主观感受的评分
- 分为**普适性量表**（通用）和**特异性量表**（针对特定疾病或人群）
- 普适性量表如 SF-36、WHOQOL、EQ-5D，适用于各类人群比较
- 特异性量表如癌症患者 QOL 量表（FACT-G）、关节炎影响测量量表（AIMS）等

2. 访谈法：

- 通过深入访谈了解受访者对生活质量的真实感受和体验
- 可获取量化量表无法捕捉的个性化信息

3. 健康效用值法：

- 将健康状态量化为一个 0（死亡）到 1（完全健康）之间的效用值
- 用于质量调整寿命年（QALY）的计算
- 方法：标准博弈法（SG）、时间权衡法（TTO）、等级评定法（RS）

12.3 生命质量的测量工具

表 12.1: 常用生命质量测量工具		
量表	开发者	特点
SF-36	美国 MOS（医学结局研究）	使用最广泛的普适性量表，36 条目 8 维度（躯体功能、躯体角色、躯体疼痛、总体健康、活力、社会功能、情绪角色、心理健康）
WHOQOL-100/WHOQOL-BREF	WHO	跨文化适用性最强，BREF 版含 26 题 4 维度（生理、心理、社会关系、环境）
EQ-5D	EuroQol Group	简洁的效用值量表，含 5 维度（行动能力、自我照顾、日常活动、疼痛/不适、焦虑/抑郁）+ VAS 自评，广泛用于药物经济学评价
疾病特异性量表	各领域开发	如 FACT（癌症）、AIMS（关节炎）、PDQ-39（帕金森病）等，对特定疾病的敏感度更高

12.4 生命质量评价的应用

- 临床疗效评价**——不仅评价是否“治好病”，还要评价“活得怎么样”。肿瘤治疗中从“生存率”到“生存质量”的评价转变
- 卫生服务效果评价**——比较不同干预方案和治疗措施对患者生命质量的综合影响
- 药物经济学评价**——结合 QOL 效用值计算 QALY（质量调整寿命年），为卫生经济决策提供依据： $QALY = 生命年 \times 健康效用值$
- 人群健康监测**——定期评估人群生命质量，发现高危人群和弱势群体
- 卫生政策制定**——为资源配置和政策决策提供人群主观健康状态的数据支持
- 老龄化研究**——评估老年人群的生命质量和功能状态，指导长期照护政策

12.5 复习题

一、选择题

1. 使用最广泛的普适性生命质量量表是：
(A) FACT-G
(B) SF-36
(C) PDQ-39
(D) AIMS
2. WHOQOL-BREF 包含几个维度？
(A) 2 个
(B) 4 个
(C) 8 个
(D) 10 个
3. EQ-5D 主要用于：
(A) 社区健康调查
(B) 药物经济学评价（效用值测量）
(C) 心理评估
(D) 体能测试
4. QALY 的全称是：
(A) 健康期望寿命
(B) 伤残调整生命年
(C) 质量调整寿命年
(D) 潜在寿命损失年

二、名词解释

1. 健康相关生命质量（HRQOL）
2. 质量调整寿命年（QALY）
3. 健康自评（Self-rated Health）

三、简答题

1. 简述生命质量的主要构成维度。
2. 简述普适性量表与特异性量表的区别及各自的适用场景。
3. 简述生命质量评价在临床医学和卫生决策中的应用。

参考答案要点

一、选择题

1. (B); 2. (B); 3. (B); 4. (C)

二、名词解释

1. **HRQOL**: 在疾病、损伤及医疗干预影响下，与个人生活事件相联系的主观健康状态和个体满意度。
2. **QALY**: 将生存年数乘以该年数中的健康效用值（0-1），综合反映生命的“数量”和“质量”，用于卫生经济学评价。
3. **健康自评**: 个体对自己健康状况的总体主观评价，是生命质量评价中最简单有效的方法之一，也是死亡和患病的重要预测因子。

三、简答题

1. 五个维度：生理状态（身体功能、疾病症状）、心理状态（情绪、认知、自我评价）、社会功能状态（社会角色、人际交往、社会参与）、角色功能（工作学习能力）、总体健康感受和满意度。
2. 普适性量表（如 SF-36、WHOQOL）：适用于各类人群间的比较，范围广但敏感度稍低。特异性量表（如 FACT、AIMS）：针对特定疾病或人群，敏感度高、变化反映更精确，但不能跨疾病比较。
3. 临床：评价疗效不仅看“是否治好”还看“活得怎样”；比较不同治疗方案对 QOL 的影响。卫生决策：结合效用值计算 QALY 进行药物经济学评价；监测人群 QOL 发现弱势群体；辅助资源配置和政策决策。

本章导览：掌握人群健康状况的复合型评价指标（PYLL、DALY 等）和社会发展指标（HDI、ASHA、PQI 等）（**教学难点**）；掌握初级卫生保健的概念、基本原则和要素；熟悉社会卫生状况的概念和评价程序；了解中国及全球社会卫生状况、全球卫生策略和可持续发展目标。

13.1 社会卫生状况概述

[概念] 概念释义：社会卫生状况（Social Health Status）：一定时空范围内，人群的健康状况以及影响人群健康的各种社会因素的综合状况。
人群健康状况：人群的整体健康水平，通过死亡率、发病率、期望寿命等一系列指标来测量和评价。
影响人群健康的社会因素：

- 社会经济发展水平
- 人口特征（数量、结构、素质、流动）
- 社会文化背景（教育、文化、宗教、风俗）
- 生活和工作环境条件
- 卫生服务系统（资源配置、可及性、质量）

13.1.1 社会卫生状况评价

1. **评价资料来源：** 人口普查数据； 生命登记系统（出生、死亡统计）； 疾病监测系统； 卫生服务常规报表； 专题调查（如国家卫生服务调查）； 国际组织数据库（WHO、UNICEF、世界银行等）
2. **评价程序：** 确定评价目标 → 选择评价指标 → 收集数据 → 分析与比较（横向对比不同地区、纵向比较不同时期）→ 发现问题与提出建议
3. **评价意义：** 全面了解人群健康状况和主要卫生问题； 明确卫生工作的重点和优先领域； 评价卫生政策和干预措施的效果； 为卫生资源配置提供依据

13.2 人群健康状况的评价指标

13.2.1 单一型指标

表 13.1: 常用单一型健康指标

指标类型	具体指标
死亡指标	死亡率、年龄别死亡率、婴儿死亡率（IMR）、5 岁以下儿童死亡率（U5MR）、孕产妇死亡率（MMR）、死因别死亡率
发病指标	发病率、患病率、疾病构成比
残疾指标	残疾发生率、残疾现患率
营养指标	低出生体重率、5 岁以下儿童低体重率、发育迟缓率
期望寿命	出生期望寿命（Life Expectancy at Birth）、健康期望寿命（HALE）

13.2.2 复合型指标（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）主要复合型健康指标：

1. 潜在寿命损失年（Potential Years of Life Lost, PYLL）：

- 定义：某年龄组人群因某病死亡而损失的寿命年数
- 计算公式： $PYLL = \sum D_x \times (L - x)$ ，其中 D_x = 年龄 x 的死亡人数， L = 标准寿命上限（通常为 70 岁）， x = 死亡年龄的中点
- 意义：强调“早死”对寿命的损失，给予年轻死亡更高的权重
- 应用：确定优先干预的疾病和健康问题

2. 无残疾期望寿命（Disability-Free Life Expectancy, DFLE/LEFD）：

- 以无残疾状态下的期望寿命来评价人群健康水平
- 扣除了因残疾而损失的寿命年

3. 活动期望寿命（Active Life Expectancy, ALE）：

- 日常生活中能保持自理能力、无依赖的期望寿命年限
- 对老年人群的健康评价尤为重要

4. 伤残调整寿命年（Disability Adjusted Life Year, DALY）：

- **目前最广泛使用的疾病负担综合评价指标**
- $DALY = YLLs$ （早死生命损失年）+ $YLDs$ （伤残生命损失年）
- 综合考虑了早死和失能两种健康损失
- 用于疾病负担（Global Burden of Disease, GBD）研究
- 意义：一个 DALY 代表因早死或伤残而损失的一年“完全健康”生命
- 可比较不同疾病、不同地区、不同时期的疾病负担
- **DALY 的局限性：** 年龄权重和贴现率的选择有争议； 残疾权重的主观性； 未考虑共存疾病的影响； 数据不足影响低收入国家的精确性； 未包括社会环境因素对疾病负担的影响

5. 健康期望寿命（Healthy Life Expectancy, HALE）：

- 以“完全健康状态”的期望寿命来衡量人群健康水平
- WHO 自 2000 年起定期发布各成员国的 HALE 数据

13.3 健康影响因素指标

13.3.1 人口学指标

- **人口数量：**总人口数、人口密度
- **人口分布：**城乡分布、地区分布
- **性别构成：**性别比（正常 103-107）
- **年龄构成：**各年龄组占比、老龄化程度（65 岁及以上 $\geq 7\%$ 为老龄化）、抚养系数
- **人口自然增长：**出生率-死亡率 = 自然增长率

13.3.2 社会发展指标（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）主要社会发展指标：

1. 人类发展指数（Human Development Index, HDI）：

- UNDP 于 1990 年提出，综合反映社会经济发展水平
- 三个维度：健康长寿（预期寿命指数）、教育获得（教育指数）、生活水平（收入指数，按购买力平价调整的人均 GDP）
- $HDI =$ 三个维度指数的几何平均数
- 分级： ≥ 0.800 为极高人类发展水平

2. ASHA 指数（American Social Health Association Index）：

- 由美国社会健康协会提出
- 计算公式： $ASHA = (\text{就业率} \times \text{识字率} \times \text{平均期望寿命} \times \text{人均 GDP 增长率}) / (\text{出生率} \times \text{婴儿死亡率})$
- 综合反映社会经济发展和健康水平

3. 物质生活质量指数（Physical Quality of Life Index, PQLI）：

- 由婴儿死亡率、1 岁期望寿命和识字率三项指标组成

- 三项指标各赋 0-100 分，求算术平均值
 - 值越高表明生活质量越好
 - 优势：简单、易于计算、不受 GDP 影响
4. 社会进步指数（Social Progress Index, SPI）：
- 衡量社会在满足人类基本需求、建立福祉基础和创造机会三个方面表现的综合性指标

13.3.3 健康公平指标

[概念] 概念释义：健康公平（Health Equity）：不同社会群体之间不存在可避免的、不公平的健康差异。健康公平关注的是**健康差异的社会根源和可改变性**。

主要衡量指标：

- **基尼系数（Gini Coefficient）**：取值范围 0-1，衡量健康或卫生服务在人群中的不平等程度。0= 完全平等，1= 完全不平等
- **集中指数（Concentration Index）**：衡量与经济社会地位相关的健康不平等程度。正值表示健康集中在富人群体，负值表示集中在穷人群体
- **比率和差值**：不同阶层或地区健康指标之比和之差，直观反映差异大小

13.4 中国与全球社会卫生状况

13.4.1 中国社会卫生状况

！**重点掌握**：健康中国（Healthy China）——中国卫生事业发展战略：

1. 《“健康中国 2030”规划纲要》（2016 年）——将健康纳入国家发展战略的核心，提出“以人民健康为中心”的发展理念
2. **五大战略任务**：普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业
3. **核心目标**：2030 年人均期望寿命达到 79 岁（2020 年 77.3 岁），婴儿死亡率降至 5.0‰ 以下，孕产妇死亡率降至 12/10 万以下
4. **主要成就**：人均期望寿命从 1949 年的 35 岁升至 2020 年的 77.3 岁；孕产妇死亡率从 1500/10 万降至 16.9/10 万；婴儿死亡率从 200‰ 降至 5.4‰

13.4.2 全球健康状况与全球卫生

- 全球健康面临的核心挑战：传染病（艾滋病、结核病、疟疾）+ 慢性非传染性疾病（NCDs 占全球死亡 71%）+ 新发传染病 + 健康不公平
- 全球卫生：超越国界的、需要全球共同行动来解决的健康问题和挑战

13.5 全球卫生策略

13.5.1 21 世纪人人享有卫生保健

！**重点掌握**：WHO“21 世纪人人享有卫生保健”（HFA 21 世纪）：

主要内容：

1. 实现健康公平——缩小国家间和国家内部的健康差距
2. 强调生命全程健康——从围生期到老年的全程保障
3. 预防为主——重视非传染性疾病和精神卫生的预防
4. 改善卫生系统绩效——提高质量、效率、反应性和公平性

总目标（至 2020 年）：

1. 增加全体人民的期望寿命和生活质量
2. 改进国家间和国家内部的健康公平
3. 使全体人民能利用可持续的卫生系统服务

13.5.2 初级卫生保健（PHC）

[概念] 概念释义：初级卫生保健（Primary Health Care, PHC）：1978 年 Alma-Ata 宣言正式提出，是基本的卫生保健服务，是社区中个人和家庭能够普遍获得的基本卫生服务，是卫生系统的最前沿和第一级接触点，也是实现“人人享有卫生保健”目标的关键途径。

！重点掌握：初级卫生保健的基本原则：

1. **社会公平**——卫生服务应公平可及，特别关注弱势群体
2. **社区参与**——社区和个人应参与卫生服务的规划和组织
3. **成本效益**——采用技术上适宜、经济上可承担的方法和技术
4. **部门协作**——卫生部门之外的农业、教育、住房、公共工程等部门均应参与
5. **预防为主**——关注健康促进和疾病预防，而非仅仅是治疗

初级卫生保健的基本要素（8 项）：

1. 健康教育——普及健康知识
2. 合理营养与食品安全——促进适当的食物供应和营养
3. 安全饮水和基本环境卫生——足够的安全用水和基本卫生设施
4. 妇幼保健与计划生育——包括围产期保健
5. 计划免疫——主要传染病的免疫接种
6. 地方病的预防和控制
7. 常见病和伤害的适当治疗
8. 基本药物的提供

13.5.3 千年发展目标与可持续发展目标

[提示] 要点提示：可持续发展目标（SDGs）中与健康相关的目标：

SDG 3 的具体目标包括——降低全球孕产妇死亡率（ $<70/10$ 万）；消除新生儿和 5 岁以下儿童可预防的死亡；终结艾滋病、结核病、疟疾等传染病流行；将 NCDs 过早死亡减少 1/3；实现全民健康覆盖（UHC）；确保普遍获得性与生殖健康服务。

13.6 复习题

一、选择题

1. DALY 等于：
(A) $YLLs - YLDs$
(B) $YLLs + YLDs$
(C) $YLLs \times YLDs$
(D) $YLLs \div YLDs$
2. PQLI 由哪三项指标构成？
(A) 婴儿死亡率、1 岁期望寿命、识字率
(B) 婴儿死亡率、成人死亡率、GDP
(C) 识字率、GDP、期望寿命
(D) GDP、IMR、MMR
3. 初级卫生保健（PHC）是哪次会议正式提出的？
(A) 1948 年 WHO 宪章
(B) 1978 年 Alma-Ata 宣言
(C) 2000 年联合国千年首脑会议
(D) 2015 年联合国可持续发展峰会
4. 中国政府提出的“健康中国 2030”核心目标中，2030 年人均期望寿命目标为：
(A) 75 岁
(B) 77 岁
(C) 79 岁
(D) 82 岁
5. SDGs 中含多少项目标？

表 13.2: 千年发展目标（MDGs, 2000-2015）与可持续发展目标（SDGs, 2016-2030）的比较

MDGs（8 项目标）

消除极端贫困和饥饿；普及初等教育；促进性别平等；降低儿童死亡率；改善孕产妇健康；抗击艾滋病、疟疾等；确保环

By greedyCat

- (A) 8 项
- (B) 12 项
- (C) 17 项
- (D) 21 项

二、名词解释

1. 伤残调整寿命年 (DALY)
2. 潜在寿命损失年 (PYLL)
3. 初级卫生保健 (PHC)
4. 健康公平 (Health Equity)
5. 人类发展指数 (HDI)

三、简答题

1. 简述 DALY 的构成及其用途。
2. 简述初级卫生保健的五项基本原则和八项基本要素。
3. 比较 MDGs 与 SDGs 在健康相关目标上的主要区别。
4. 简述“健康中国 2030”战略的五大战略任务。

参考答案要点

一、选择题

1. (B); 2. (A); 3. (B); 4. (C); 5. (C)

二、名词解释

1. **DALY**: 伤残调整寿命年, 综合反映早死 (YLLs) 和伤残 (YLDs) 造成的健康损失, 是目前使用最广泛的疾病负担综合评价指标。
2. **PYLL**: 潜在寿命损失年, 强调“早死”造成的寿命损失, 给予年轻死亡更高的权重, 用于确定优先干预领域。
3. **PHC**: 1978 年 Alma-Ata 宣言提出的基本卫生保健, 是社区中个人和家庭能普遍获得的基本卫生服务, 是实现“人人享有卫生保健”的关键。
4. **健康公平**: 不同社会群体之间不存在可避免的、不公平的健康差异, 关注健康差异的社会根源和可改变性。
5. **HDI**: UNDP 1990 年提出, 综合反映社会经济发展水平的指标, 包括预期寿命、教育获得和生活水平三个维度。

三、简答题

1. $DALY = YLLs$ (早死生命损失年) + $YLDs$ (伤残生命损失年)。用途: 比较不同疾病/地区/时期的疾病负担; 为卫生资源配置和优先干预决策提供依据; 监测卫生策略效果。局限性: 年龄权重选择争议、残疾权重主观性、数据不足问题等。
2. 五项原则: 社会公平、社区参与、成本效益、部门协作、预防为主。八项要素: 健康教育、合理营养与食品安全、安全饮水和环境卫生、妇幼保健与计划生育、计划免疫、地方病防控、常见病和伤害适当治疗、基本药物提供。
3. MDGs (8 项目标) 主要针对发展中国家, 聚焦于贫困、疾病等基本问题; SDGs (17 项目标) 面向所有国家, 更具普遍性和综合性, 健康目标 (SDG3) 涵盖面更广, 包括 NCDs、全民健康覆盖、精神卫生等。
4. 五大任务: 普及健康生活 (健康教育、健康促进)、优化健康服务 (强化公共卫生和基本医疗服务)、完善健康保障 (健全医疗保障体系)、建设健康环境 (环境保护、食品安全)、发展健康产业 (医药、健康服务业)。

本章导览：掌握健康管理策略（教学难点）；掌握健康管理与健康治理的联系与区别；熟悉健康管理的基本步骤和核心内容；了解健康管理产生的背景、演变及现代健康管理的新特点；了解不同层次的健康管理与治理。

16.1 健康管理概述

16.1.1 健康管理产生的背景

1. **疾病谱和医学模式的转变**——慢性非传染性疾病成为主要疾病负担，要求从“治疗已病”转向“管理健康”
2. **医疗费用持续增长**——人口老龄化、新技术应用等推动医疗费用不断攀升，需要“以管理促节约”
3. **健康管理理念的兴起**——20 世纪 20-30 年代美国最早出现健康管理萌芽（1929 年 Kaiser 健康计划），60-70 年代 HMO（健康维护组织）的发展为健康管理提供了组织模式
4. **循证医学和信息技术的发展**——为健康管理的科学化和信息化提供了支撑

16.1.2 健康管理的演变

从疾病管理 → 健康管理 → 健康治理：

- 第一阶段：**疾病管理（Disease Management）**——以特定疾病患者为对象
- 第二阶段：**健康管理（Health Management）**——扩展到健康和亚健康人群
- 第三阶段：**健康治理（Health Governance）**——从管理到治理，强调多元主体参与合作

16.1.3 健康管理的概念和内涵

[概念] 概念释义：健康管理（Health Management）：以健康为中心，对**个体或群体的健康危险因素**进行全面监测、分析、评估和预测，提供健康咨询和指导，并对健康危险因素进行干预的全过程。其核心是**对健康风险的管理和控制**。

核心内涵：

1. 以健康为管理对象——而非以疾病为对象
2. 以健康风险为核心——识别、评估和干预健康危险因素
3. 以预防为导向——防患于未然，关注全生命周期
4. 强调个体主动性——调动个人积极性，自我管理健康
5. 持续动态管理——健康管理是持久、连续的过程

16.1.4 现代健康管理的新特点

1. **信息化**——电子健康档案（EHR）、移动健康（mHealth）、可穿戴设备
2. **智能化**——人工智能和大数据技术的应用
3. **个性化/精准化**——基于个体风险图谱和管理需求
4. **协同化**——多部门、多学科协同参与
5. **全生命周期化**——从出生到死亡的全程健康管理

16.2 健康管理的基本内容与步骤

16.2.1 健康管理的基本步骤

！重点掌握：健康管理的四个基本步骤：

1. **第一步：健康信息收集与监测**

- 个人基本信息（年龄、性别、家族史等）
- 健康体检信息（体格检查、实验室检查等）
- 行为生活方式信息（吸烟、饮酒、饮食、运动等）
- 心理与社会状况评估

2. **第二步：健康风险评估（HRA）**

- 评估个体或群体未来发生特定疾病或健康不良后果的风险
- 识别主要可改变的健康危险因素
- 确定干预的优先顺序

3. **第三步：健康管理计划制定**

- 设定健康改善目标（可测量、可达到、有时间限制）
- 制定个性化的干预方案（行为改善、治疗和管理方案）
- 明确实施方式和时间安排

4. **第四步：健康管理干预与评估**

- 实施健康干预（健康教育、行为矫正、临床干预等）
- 定期随访和监测
- 效果评估和计划调整

16.2.2 健康管理策略（教学难点 *）

！重点掌握：（教学难点 *）健康管理的六大基本策略：

1. **生活方式管理（Lifestyle Management）**——通过健康教育和行为干预，帮助人们采纳和维持健康的生活方式。核心手段：健康教育、激励机制、行为矫正。目标：减少健康危险行为（吸烟、酗酒、不良饮食、缺乏运动等）
2. **需求管理（Demand Management）**——运用远程医疗、健康咨询、自我管理支持等手段，帮助人们更好地利用卫生服务，避免不必要和不恰当的卫生服务使用。主要工具：24 小时电话健康咨询、在线健康信息、分诊系统
3. **疾病管理（Disease Management）**——以特定疾病患者为对象，采用系统化、协调化的服务模式，改善疾病结局。强调：循证医学指导、患者自我管理、多学科团队协作、持续质量改进。典型对象：糖尿病、高血压、哮喘、COPD 等慢性病
4. **灾难性伤病管理（Catastrophic Case Management）**——针对严重伤病或高额医疗费用病例的专门管理，通过个案管理和专业评估，在确保医疗质量的同时控制费用。要求：专业的个案管理师、综合评估和资源配置
5. **残疾管理（Disability Management）**——减少工作场所残疾发生，促进因伤病缺勤者尽早康复和重返工作。关注：早期康复介入、工作环境调整、心理支持和职业康复
6. **综合人群健康管理（Population Health Management）**——整合以上多种策略，对整个人群的健康进行系统化综合管理，强调：数据驱动的风险评估和分层管理、多策略的协调实施、跨部门协作、健康结果和成本效益评估

16.3 健康治理

[概念] 概念释义：健康治理（Health Governance）：政府、市场、社会组织、公民等**多元主体**通过协商、合作和共同行动，共同应对健康问题和挑战的持续过程。

健康治理的特点：

1. **多元主体参与**——不仅限于政府，还包括企业、社会组织、社区、公民等
2. **协商共治**——各主体间通过协商而非命令来达成共识
3. **透明和问责**——决策过程透明、各主体有明确责任并接受监督
4. **网络化治理**——治理结构从“垂直层级”转向“网络协作”
5. **全球视野**——健康问题超越国界，需要全球治理机制

16.3.1 健康管理与健康治理的联系与区别

! 重点掌握：联系：

- 健康治理是健康管理理念的延伸和升级
- 两者都强调以健康为中心、预防为主
- 健康治理为健康管理提供了更广泛的制度框架和组织支撑

区别： 表 16-1 健康管理与健康治理的比较

比较维度	健康管理	健康治理
主体	以卫生专业人员和管理者为主	多元主体（政府、市场、社会、公民）
方式	以专业手段进行管理和干预	以协商、合作、共同行动实现
对象	个体或群体的健康风险	健康的社会决定因素和系统问题
范围	侧重卫生服务领域	跨部门、跨领域的社会性治理
机制	计划、组织、协调、控制	参与、协商、透明、问责

16.4 不同层次的健康管理与治理

1. 以社区为基础的健康管理与治理——社区是健康管理和治理的基础单元。家庭医生签约服务、社区网格化管理、健康社区建设
2. 卫生系统健康管理 with 治理——医保支付方式改革（按人头付费、DRG 等）、分级诊疗、医联体、信息化建设
3. 国家健康管理 with 治理——制定国家健康战略（如” 健康中国 2030”）、健康立法、多部门协调机制（爱国卫生运动委员会）
4. 全球健康治理——WHO 在全球健康治理中的核心作用、国际卫生条例（IHR）、全球基金（GFATM）、新发传染病的全球应对机制

16.5 复习题

一、选择题

1. 健康管理的核心是：

(A) 疾病治疗

(B) 健康风险的管理和控制

(C) 药品管理

(D) 医院管理
2. 以下哪项不是健康管理的四大基本步骤之一？

(A) 健康信息收集与监测

(B) 健康风险评估

(C) 疾病诊断与治疗

(D) 健康管理干预与评估
3. 健康管理与健康治理的最主要区别在于：

(A) 前者是治疗，后者是预防

(B) 前者以专业人员为主，后者强调多元主体参与

(C) 前者关注个体，后者不关注个体

(D) 两者没有区别
4. 健康管理中” 灾难性伤病管理” 的主要对象是：

(A) 所有慢性病患者

(B) 健康人群

(C) 严重伤病或高额医疗费用病例

(D) 亚健康人群

二、名词解释

1. 健康管理（Health Management）

2. 健康治理 (Health Governance)

3. 生活方式管理

三、简答题

1. 简述健康管理的六大基本策略。
2. 简述健康管理的基本步骤。
3. 试述健康管理与健康治理的联系与区别。
4. 简述现代健康管理的新特点。

参考答案要点

一、选择题

1. (B); 2. (C); 3. (B); 4. (C)

二、名词解释

1. **健康管理**: 对个体或群体的健康危险因素进行全面监测、分析、评估和干预的全过程, 核心是对健康风险的管理和控制。
2. **健康治理**: 多元主体 (政府、市场、社会、公民) 通过协商合作共同应对健康问题和挑战的持续过程。
3. **生活方式管理**: 通过健康教育和行为干预帮助人们采纳和维持健康生活方式的策略, 核心手段包括健康教育、激励机制和行为矫正。

三、简答题

1. 六大策略: 生活方式管理 (健康教育 + 行为干预); 需求管理 (减少不必要服务使用); 疾病管理 (慢性病系统化管理); 灾难性伤病管理 (严重病例个案管理); 残疾管理 (促进康复和重返工作); 综合人群健康管理 (数据驱动、多策略协调)。
2. 四步: 信息收集监测 → 健康风险评估 (HRA) → 制定管理计划 → 干预实施与效果评估。
3. 联系: 治理是管理的延伸升级, 都以健康为中心。区别: 管理以专业人员为主体, 侧重技术手段和风险控制; 治理以多元主体参与为特征, 侧重协商合作和制度建设, 范围更广泛 (跨部门 vs. 卫生服务领域)。
4. 五大新特点: 信息化 (EHR、mHealth)、智能化 (AI、大数据)、个性化/精准化、协同化 (多部门多学科)、全生命周期化。

本章导览：掌握社区卫生服务的特点和管理（**教学难点**）；熟悉社区卫生服务的概念、对象、内容及全科医学的相关概念；了解社区卫生服务的发展概况、方式及绩效评价。

17.1 社区与社区卫生服务概述

17.1.1 社区的定义、类型与要素

[概念] 概念释义：社区（Community）：由一定数量的人群组成，他们居住在共同的地理环境之中，具有共同的文化、共同的生活方式和共同的利益，拥有共同的社会组织和社会服务体系。

最早的社区定义：1887 年德国社会学家 Ferdinand Tönnies 提出“Gemeinschaft”（社区/共同体）概念，区别于“Gesellschaft”（社会）。

中国社区的概念：1933 年费孝通等学者将英文“Community”译为“社区”。

WHO 的社区定义：一个代表性的社区，其人口数大约在 10 万-30 万之间，面积在 0.5 万-5 万平方公里。

社区的要素与类型

构成社区的五大要素：

1. 一定数量的人群——社区的主体
2. 一定的地域范围——社区的空间载体
3. 共同的文化和生活方式——社区的纽带
4. 共同的利益和认同感——社区的凝聚力
5. 一定的社会组织和服务体系——社区的运作机制

社区类型：

- 按人口分布：城市社区、农村社区、城乡结合部社区
- 按功能特征：居住型社区、工作型社区、混合型社区
- 按形成方式：自然形成社区、规划设置社区（如街道办事处辖区、居委会辖区）

17.1.2 社区卫生服务的概念与对象

[概念] 概念释义：社区卫生服务（Community Health Service, CHS）：在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以**基层卫生机构为主体**，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为重点服务对象，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融**预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务**等于一体的有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

！重点掌握：社区卫生服务的对象：

1. **健康人群**——提供健康促进和疾病预防服务
2. **亚健康人群**——早期发现健康问题，进行健康管理
3. **高危人群**——重点监测和干预健康危险因素
4. **重点保健人群**——妇女、儿童、老年人
5. **患者**——常见病、多发病的诊治和慢性病管理

17.1.3 全科医学

[概念] 概念释义：全科医学/家庭医学（General Practice / Family Medicine）：整合临床医学、预防医学、康复医学及人文社会科学相关内容于一体的综合性医学专业学科，是服务于社区、以家庭为单位、以个人为中心的**连续性、综合性、协调性**的基层医疗保健专业。

全科医师（General Practitioner, GP）：经过全科医学专业培训的医生，是社区卫生服务的骨干力量，提供第一线的全面、连续的卫生保健服务。

17.2 社区卫生服务的特点与内容

17.2.1 社区卫生服务的特点（教学难点 *）

！重点掌握：（教学难点 *）社区卫生服务的六大特点：

1. **以健康为中心（Health-centred）**——以保护和促进人群健康为目标，而非仅仅“治病”。强调“以人的健康为中心”，关注全人群和全生命周期健康
2. **以需求为导向（Demand-oriented）**——根据社区居民的实际健康需求和主要健康问题来规划和组织服务，服务内容和方式与社区需求相匹配
3. **以家庭为单位（Family as a Unit）**——将家庭作为服务的基本单元，关注家庭结构、功能对成员健康的影响。家庭是健康行为养成和社会支持的核心场域：
 - 家庭影响健康行为的形成和维持
 - 家庭关系提供情感支持和疾病照护
 - 家庭功能障碍可成为疾病诱因
 - “一人患病，全家受累”——家庭疾病负担传递
4. **以社区为范围（Community-based）**——服务涵盖整个社区，关注社区整体健康状况和社区环境对健康的影响
5. **预防为主（Prevention-focused）**——将预防贯穿于医疗卫生服务的始终。社区是三级预防的最佳场所：一级预防（健康教育、预防接种）、二级预防（筛查、早期诊断）、三级预防（慢性病管理、康复）
6. **综合性、连续性和协调性服务**——六位一体综合服务（预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育）。连续性——从围生期到临终的生命全程服务；首次接触（First Contact）——社区卫生服务是居民进入卫生系统的第一站，解

17.2.2 社区卫生服务的内容

1. **预防服务**：健康教育、计划免疫、传染病防控、慢性病预防与控制
2. **医疗服务**：常见病和多发病的诊疗、院前急救、家庭病床
3. **保健服务**：妇女保健、儿童保健、老年保健、重点人群健康管理
4. **康复服务**：社区康复、慢性病康复、残疾人士社区康复
5. **健康教育**：健康知识普及、健康行为指导、健康技能培训
6. **计划生育技术服务**：避孕节育指导、优生优育咨询

17.3 社区卫生服务发展概况

17.3.1 国际发展

- 1945 年：英国工党政府开始建立 NHS（国家卫生服务），确立全科医师“守门人”制度
- 20 世纪 50-60 年代：日本、澳大利亚等国先后建立社区/家庭医学体系
- 1978 年：Alma-Ata 宣言推动全球社区卫生服务和初级卫生保健发展

17.3.2 中国发展

1. 1997 年：《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》明确发展社区卫生服务
2. 1999 年：十部委发布《关于发展城市社区卫生服务的若干意见》
3. 2002 年：十一部委发布《关于加快发展城市社区卫生服务的意见》
4. 2006 年：《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》出台
5. 2009 年：新医改将社区卫生服务作为“保基本、强基层、建机制”的重点
6. 2011 年：全面推行家庭医生签约服务

7. 2015 年：《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》强化社区首诊
8. 2016 年：《“健康中国 2030”规划纲要》将社区卫生服务作为基层医疗核心
9. 2018 年：《关于加强公立医院党的建设工作的意见》推进医联体建设

17.4 社区卫生服务的管理（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）社区卫生服务管理的核心要点：

1. 组织管理：

- 社区卫生服务中心（站）的设置标准（服务人口：城市 3-10 万人/中心，农村乡镇）
- 运行机制：政府主导、公益性原则

2. 人员管理：

- 全科医师（GP）为核心的团队建设
- 家庭医生签约服务团队（GP+ 护士 + 公卫医师等）
- 继续教育和能力提升

3. 服务质量管理：

- 临床路径和诊疗规范
- 双向转诊制度
- 绩效考核和质量评价

4. 经费与医保管理：

- 财政投入保障（政府购买服务、基本公共卫生服务均等化资金）
- 医保支付方式改革（按人头付费、总额预付等）

17.4.1 服务方式与绩效评价

- **服务方式：**门诊服务、上门服务（家庭病床、出诊）、社区巡诊、电话咨询服务、网络健康管理、家庭医生签约服务
- **绩效评价：**服务覆盖率（健康档案建档率、计划免疫接种率等）、服务质量（慢性病管理率、血压/血糖控制率等）、居民满意度、服务效率（门诊人次、住院床日等）、费用控制效果

17.4.2 社区卫生服务的意义

1. **体现社会公平**——使全体居民特别是弱势群体享受到基本卫生服务
2. **合理利用卫生资源**——常见病多发病在基层解决，缓解大医院“看病难”
3. **提高卫生服务效率**——通过分级诊疗和双向转诊优化资源配置
4. **降低医疗费用**——社区首诊和健康管理减少不必要的高成本服务
5. **实现医学模式转变**——社区卫生服务是生物-心理-社会医学模式的最佳实践场所

17.5 复习题

一、选择题

1. 社区卫生服务的核心骨干是：
(A) 专科医师
(B) 全科医师
(C) 公共卫生医师
(D) 护士
2. 社区卫生服务的特点不包括：
(A) 以健康为中心
(B) 以家庭为单位
(C) 以专科医疗为重点
(D) 预防为主
3. 社区卫生服务的“六位一体”不包括：
(A) 预防
(B) 医疗
(C) 器官移植

(D) 健康教育

4. 将"Community"译为"社区"的中国学者是：

- (A) 陈志潜
- (B) 费孝通
- (C) 吴阶平
- (D) 兰安生

二、名词解释

1. 社区卫生服务 (CHS)
2. 全科医学 (General Practice)
3. 社区 (Community)

三、简答题

1. 试述社区卫生服务的六大特点。
2. 简述社区卫生服务的"六位一体"内容。
3. 简述社区卫生服务的重要意义。
4. 简述我国社区卫生服务的发展历程。

参考答案要点

一、选择题

1. (B); 2. (C); 3. (C); 4. (B)

二、名词解释

1. **CHS**: 以基层卫生机构为主体、全科医师为骨干, 融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务于一体, 以健康为中心、家庭为单位、社区为范围的基层卫生服务。
2. **全科医学**: 整合临床、预防、康复及人文社会科学的综合性医学专业学科, 提供连续性、综合性、协调性的基层医疗保健。
3. **社区**: 由一定数量人群组成, 居住在共同地域, 具有共同文化、生活方式和利益, 拥有共同社会组织和服务体系的社会单位。

三、简答题

1. 六大特点: 以健康为中心 (非仅"治病"); 以需求为导向 (服务与需求匹配); 以家庭为单位 (关注家庭对健康的影响); 以社区为范围 (关注社区整体健康); 预防为主 (三级预防的理想场所); 综合性、连续性和协调性 (六位一体 + 生命全程 + 首诊制)。
2. 六位一体: 预防 (健康教育 + 免疫接种 + 传染病防控)、医疗 (常见病诊疗 + 急救)、保健 (妇幼 + 老年 + 重点人群)、康复 (社区康复 + 慢性病康复)、健康教育 (知识普及 + 行为指导)、计划生育技术服务 (避孕节育 + 优生优育)。
3. 五大意义: 体现社会公平 (弱势群体可及性)、合理利用资源 (基层首诊缓解大医院压力)、提高效率 (分级诊疗 + 双向转诊)、降低费用 (社区首诊减少高成本服务)、实现医学模式转变 (BPS 模式最佳实践场所)。
4. 重要里程碑: 1997 年中央决定发展 CHS; 1999 年十部委意见; 2006 年国务院指导意见; 2009 年新医改"保基本强基层"; 2011 年家庭医生签约; 2015 年分级诊疗制度; 2016 年健康中国 2030。

本章导览：掌握社会病的概念、特点及人际暴力的相关理论（**教学难点**）；熟悉自杀的概念、分类、分布特征和社会根源；了解攻击、暴力、非故意伤害、成瘾行为、吸毒以及与性行为相关的社会病等问题。

21.1 社会病概述

[概念] 概念释义：社会病（Sociopathy / Social Pathology）：由于社会原因（社会制度、社会结构、社会文化、社会转型等）而产生的**损害社会功能和人群健康**的社会问题。社会病既是社会问题（社会层面的功能失调），也是健康问题（对人群身心健康造成严重损害）。

辨析：社会病与社会问题、越轨行为

- **社会问题（Social Problem）**：广义上任何影响社会正常运行的问题，社会病是社会问题中对人群健康影响最直接的一类
- **越轨行为（Deviant Behavior）**：偏离或违反社会规范的行为，多数社会病涉及越轨行为，但并非所有越轨行为都是社会病
- **反社会人格障碍（Antisocial Personality Disorder）**：精神医学诊断，主要表现为长期漠视和侵犯他人权利的行为模式，与社会病概念不同但有一定交叉

21.1.1 社会病的特点

！重点掌握：社会病的五大特点：

1. **社会根源性**——社会病的根源在于社会因素（社会不平等、制度缺陷、文化冲突等），而非纯粹的个体生物学问题或个体道德问题
2. **群体性/流行性**——社会病涉及一定规模的人群，具有一定的流行特征
3. **严重危害性**——对社会公共安全、社会秩序、经济发展和人群身心健康造成严重危害
4. **复杂性和综合性**——社会病的成因复杂多元，涉及多个层面：个体因素与宏观社会因素相互交织，往往与贫困、教育程度低、社会歧视等社会不利条件相关
5. **可预防性**——可以通过社会政策、法制建设、教育宣传等社会干预手段有效预防和控制

21.2 攻击与暴力

21.2.1 基本概念

[概念] 概念释义：攻击（Aggression）：以伤害他人或损害物体为目的的行为。可以分为：工具性攻击（以达成某种目标为目的）和敌意性攻击（以伤害他人本身为目的）。

暴力（Violence）：故意运用躯体力量或权力，对自身、他人、群体或社会进行威胁或伤害，造成或极有可能造成损伤、死亡、心理伤害、发育不良或剥夺的行为。

21.2.2 人际暴力（教学难点*）

！重点掌握：（教学难点*）人际暴力（Interpersonal Violence）：

WHO 将暴力分为三大类：

1. **自我指向暴力（Self-directed Violence）**：自杀行为（自杀、自杀未遂、自杀意念）、自伤行为
2. **人际暴力（Interpersonal Violence）**：家庭暴力/亲密伴侣暴力（配偶虐待、儿童虐待、老年人虐待）、社区暴力（熟人暴力和陌生人暴力）
3. **集体暴力（Collective Violence）**：社会暴力、政治暴力、经济暴力

家庭暴力（Domestic Violence）的特点：

- 隐蔽性强——发生在家庭内部，不易为外人所知
- 反复性和循环性——暴力往往呈周期性循环模式
- 多重伤害——造成躯体、心理和社会功能的全面损害
- 代际传递——暴力家庭中成长的儿童成年后更可能成为施暴者或受害者

暴力的社会根源：

1. 社会不平等——贫富差距、社会排斥
2. 社会文化因素——暴力亚文化、“荣誉”文化、性别不平等
3. 社会解组——传统社会规范和约束机制失效
4. 酒精和药物滥用——降低行为控制力
5. 儿童期不良经历（ACEs）——遭受虐待或忽视

21.3 自杀

[概念] 概念释义：自杀（Suicide）：个体在意识清晰的情况下，自愿地采取某种手段结束自己生命的行为。
自杀行为的分类：

1. **自杀意念（Suicidal Ideation）**——有结束生命的想法但未付诸行动
2. **自杀未遂（Attempted Suicide）**——实施了自杀行为但未导致死亡
3. **自杀死亡（Completed Suicide）**——自杀行为导致死亡

21.3.1 自杀的发生率与分布特征

！重点掌握：

- 全球：每年约 80 万人死于自杀（每 40 秒 1 人），自杀未遂人数约为自杀死亡人数的 20 倍
- 中国：曾经是全球自杀率最高的国家之一（1990 年代年自杀率约 23/10 万），近年来显著下降（约 7/10 万），这与社会经济发展和农药管理改善有关
- 中国自杀的独特模式：**农村显著高于城市**（3-5 倍，主要与农药可及性高有关）；老年人为最高风险人群；中国女性自杀率曾高于男性（全球大多数国家男性高于女性），近年已趋近国际模式
- 全球：自杀死亡以男性为主（男性: 女性 $\approx$ 3:1），但自杀未遂以女性居多
- 高危人群：老年人、青少年（15-29 岁第二大死因）、精神障碍患者、LGBTQ 群体

21.3.2 自杀的社会根源

1. **社会整合不足**——Durkheim 的自杀理论：利己型自杀（社会整合不足）和失范型自杀（社会规范缺失）
2. **精神障碍**——抑郁症、物质成瘾、精神分裂症等是最重要的危险因素
3. **社会孤立**——缺乏社会联系和支持网络
4. **经济压力**——失业、债务、贫困等经济因素
5. **社会文化因素**——某些文化中自杀被视为“光荣”行为
6. **媒体效应**——不当的自杀报道可引发模仿自杀（Werther 效应）

21.3.3 自杀的预防

1. 限制自杀手段的可及性——农药管理、枪支管控、高层建筑和高桥防护
2. 早期识别和干预——高危人群筛查和跟踪；危机干预热线（24 小时心理援助热线）
3. 加强精神卫生服务——提高抑郁症等精神障碍的识别率和治疗率
4. 负责任的媒体报道——遵循 WHO 自杀报道指南，减少 Werther 效应
5. 加强社会支持——社区关怀、家庭支持、社会再融入

6. 综合性国家自杀预防战略——WHO 建议各国制定国家层面的自杀预防战略

21.4 非故意伤害

[概念] 概念释义：非故意伤害（Unintentional Injury）：由于非故意的意外事件造成的躯体伤害，包括交通事故、跌倒、溺水、中毒、烧伤等。非故意伤害是全球重要的公共卫生问题，是儿童和青少年死亡的重要原因。

主要类型：交通事故伤害（全球第八大死因，每年约 135 万人死亡）、跌倒（老年人最主要伤害原因）、溺水（1-14 岁儿童首位伤害死因）、中毒、烧伤和烫伤。

21.5 成瘾行为

21.5.1 吸毒

！重点掌握：吸毒（Drug Abuse/Addiction）的健康和社会危害：

1. 对个体的危害——躯体健康损害（器官衰竭、药物过量死亡）、精神障碍（精神病性症状）、HIV/AIDS 和肝炎通过共用针具传播、社会功能丧失
2. 对家庭和社会的危害——家庭破裂和经济崩溃、药物相关的犯罪（暴力、盗窃）、社会生产力的巨大损失、社会治理成本急剧增加

吸毒的社会防治：

1. 法律和执法——严厉打击毒品贩运和生产
2. 预防教育——学校、社区和家庭的毒品预防教育
3. 减害策略（Harm Reduction）——美沙酮维持治疗（MMT）、针具交换项目（NSP）
4. 治疗和康复——社区戒毒、强制隔离戒毒、自愿戒毒，重点是回归社会

21.5.2 问题饮酒行为

[概念] 概念释义：问题饮酒（Problem Drinking）：饮酒导致健康损害、社会功能受损或法律问题的饮酒模式。包括酒精滥用（Alcohol Abuse）和酒精依赖（Alcohol Dependence/Alcoholism）。

过量饮酒的健康危害：肝脏疾病（酒精性肝炎、肝硬化、肝癌）、心血管疾病、多种癌症（口腔、咽喉、食管、肝癌等）、神经系统损害、胎儿酒精综合征。

21.6 与性行为相关的社会病

1. **性传播疾病（STDs）**——艾滋病（AIDS）、梅毒、淋病、尖锐湿疣等。全球约 3800 万 HIV/AIDS 感染者；性传播是我国 HIV 的主要传播途径
2. **青少年妊娠（Teenage Pregnancy）**——青少年因身心发育未成熟和缺乏社会支持，面临更高的孕产期并发症风险，同时造成教育中断和社会经济劣势的代际循环
3. **性暴力**——严重侵犯人权的社会问题，给受害者造成长期的身心创伤

社会防治：综合性性教育、提高避孕意识和可及性、安全套推广（针对于 STDs 和 HIV）、反对性暴力和加强社会保护。

21.7 精神障碍

[概念] 概念释义：精神障碍（Mental Disorders）：以认知、情绪、行为异常为主要表现的一大类精神疾病的总称。

精神障碍不仅是医学问题，也是重要的**公共卫生和社会问题**——全球约 10 亿人患有精神障碍，精神障碍占全球 DALY 的 7% 以上。由于病耻感（STIGMA），大多数患者未能获得适当治疗。

21.8 复习题

一、选择题

1. 社会病的首要特点是：
(A) 生物因素为主
(B) 社会根源性
(C) 不可预防性
(D) 个体道德问题
2. WHO 将暴力分为三大类，不包括：
(A) 自我指向暴力
(B) 人际暴力
(C) 财产暴力
(D) 集体暴力
3. Durkheim 将自杀分为四种类型，其中社会整合不足导致的是：
(A) 利己型自杀
(B) 利他型自杀
(C) 失范型自杀
(D) 宿命型自杀
4. 减害策略 (Harm Reduction) 不包括以下哪项？
(A) 美沙酮维持治疗
(B) 针具交换项目
(C) 鼓励吸毒
(D) 安全套推广
5. 以下哪个群体是自杀风险最高的年龄段之一？
(A) 5-10 岁儿童
(B) 15-29 岁青少年/青年 (第二大死因)
(C) 30-40 岁中年人
(D) 50-60 岁中年人

二、名词解释

1. 社会病 (Social Pathology)
2. 自杀 (Suicide)
3. 越轨行为 (Deviant Behavior)
4. 减害策略 (Harm Reduction)

三、简答题

1. 简述社会病的特点。
2. 简述 WHO 对暴力的三大分类及人际暴力的主要类型。
3. 简述自杀的社会根源及预防策略。
4. 简述吸毒对个体和社会的主要危害。

参考答案要点

一、选择题

1. (B); 2. (C); 3. (A); 4. (C); 5. (B)

二、名词解释

1. **社会病**：由于社会原因产生的损害社会功能和人群健康的社会问题，具有社会根源性、群体性、严重危害性、复杂性和可预防性等特点。
2. **自杀**：个体在意识清晰的情况下自愿采取某种手段结束自己生命的行为，包括自杀意念、自杀未遂和自杀死亡。
3. **越轨行为**：偏离或违反社会规范的行为，多数社会病涉及越轨行为，但并非所有越轨行为都是社会病。

4. **减害策略：**以减少药物滥用负面后果（而非强制禁绝）为目标的公共卫生策略，如美沙酮维持治疗、针具交换项目。

三、简答题

1. 五大特点：社会根源性（根源于社会不平等和制度缺陷）、群体性（涉及较大规模人群）、严重危害性（公共安全和身心健康）、复杂性和综合性（多层面因素交织、与社会不利条件相关）、可预防性（社会政策、法制、教育等措施有效）。
2. 三大类：自我指向暴力（自杀、自伤）；人际暴力（家庭暴力/亲密伴侣暴力、社区暴力）；集体暴力（社会、政治、经济暴力）。人际暴力主要类型：家庭暴力（配偶、儿童、老年人虐待）和社区暴力（熟人暴力和陌生人暴力）。
3. 社会根源：社会整合不足（Durkheim 理论）、精神障碍、社会孤立、经济压力、文化因素、媒体效应（Werther 效应）。预防策略：限制自杀手段可及性、高危人群筛查和危机干预、加强精神卫生服务、负责任媒体报道、加强社会支持、制定国家自杀预防战略。
4. 个体危害：躯体健康损害（器官衰竭、药物过量死亡）、精神障碍、传染病传播（共用针具 → HIV/AIDS/肝炎）、社会功能丧失。社会危害：家庭破裂与经济崩溃、药物相关犯罪、社会生产力损失、治理成本增加。